保证伦理审查的质量与时效。在突发公共事件等紧急状态下，应根据事件紧急程度实行分级管理，及时启动应急程序审查。

1. 审查时限　对突发公共事件等紧急状态的科技活动，应及时启动应急程序审查，一般应在72小时内实施伦理审查并出具审查意见，并不得降低伦理审查的要求和质量。对于适用专家复核程序的科技活动，专家复核时间一并计入应急程序审查时间。医学伦理委员会在正式受理应急程序审查申请后，应立即转发给各位委员。收到审查申请材料后，委员应尽快开展审查，并提交审查意见。伦理委员会应形成伦理审查决定及时传达给科技活动负责人。

2. 审查人员及审查方式　应急程序审查应有相关专业领域的委员参与；无相关专业领域委员的，应邀请相关领域顾问专家提供咨询意见。必要时，可以采用网络视频会议审查形式，委员应尽可能为应对突发公共事件等紧急状态的科技活动投入额外精力。

3. 制度保障　医学伦理委员会应制定科技伦理应急审查制度，明确突发公共事件等紧急状态下的应急审查流程和标准操作规程，组织开展应急伦理审查培训。

三、医学伦理审查的主要内容

（一）医学研究的伦理审查内容

1. 涉及人的生命科学和医学研究伦理审查的主要内容　当前以研究参与者及其生物样本、信息数据（包括健康记录、行为等）开展的生命科学和医学研究活动，从伦理审查内容上看，因研究类型的不同，伦理审查要点各有侧重。结合目前医学伦理审查工作的实际，需要重点掌握药物和医疗器械临床试验伦理审查、社会学与行为学研究伦理审查、干细胞临床研究伦理审查的主要内容。

（1）药物和医疗器械临床试验伦理审查的主要内容：包括研究者的资格、经验、技术能力等符合试验要求；研究方案科学，有充足的临床前研究依据，并符合伦理原则；中医药项目研究方案的审查，还应当考虑其传统实践经验；纳入和排除标准公平合理；研究参与者可能遭受的风险损害与研究预期的受益相比在合理范围之内；对研究参与者在研究中可能承受的风险有预防和应对措施；知情同意书提供的有关信息完整易懂，获得知情同意的过程合规正当；向研究参与者明确告知其应当享有的权益，包括在研究过程中可以随时无理由退出且不受歧视的权利等；对研究参与者参加研究的合理支出给予合理补偿；研究参与者参加研究受到损害时，可以获得及时的治疗和合理赔偿；由具备资格或者经培训后的研究者负责获取知情同意，并随时接受有关安全问题的咨询；对研究中涉及的利益冲突进行必要的规避和管理；充分评估研究可能存在的社会舆论风险；其他需要审查的内容。

（2）社会学与行为学研究伦理审查的主要内容：以心理学、社会学、行为学、人类学、政治学、经济学和人文科学为代表的社会学与行为学研究，其研究类别主要包括：实验室研究、田野实验、自然行为直接观察类研究、访谈调查、已有数据的二次研究等。

社会学与行为学研究与生物医学研究的伦理审查流程、审查要素基本相同，但因自身的特点，实际工作中需格外注意如下要点。

第一，要结合社会学和行为学研究的专业特点，应安排心理学、社会学或行为学专业委员担任主审，确保审查质量。

第二，要重点关注研究参与者的心理伤害、歧视和污名化、财务损失、信息泄露等社会伤害，正确评估最低风险，如一个常规的心理测试对一个严重抑郁症患者带来的风险很可能大于最低风险。

第三，要审慎判定免除知情同意或免除知情同意书签字的情况。知情同意是保护研究参与者权益的重要环节。但有些情况下，免除知情同意也可以得到伦理上的辩护，甚至有些情况下免除签署书面的知情同意，更有利于对研究参与者的保护。当研究符合下列全部条件时，伦理委员会可以免除知情同意：研究不大于最低风险；免除知情同意不会影响研究参与者的权益；如不免除知情同意，则研究无法实行；在任何适当的时候，研究参与者结束研究后需得到相关信息。还有些情况下，知情同意文件是联系研究参与者和研究的唯一记录，且研究主要伤害的风险来自泄密。这时研究者需要询问每

一位研究参与者是否愿意保留说明其与研究关联的文件，要尊重研究参与者的真实意愿。如果研究参与者不同意，可以免除知情同意书签字。

第四，欺瞒性研究应做到及时的事后说明。有些社会学及行为学研究可能会有目的地操控一些研究环境，在研究的某些方面隐瞒或欺骗研究参与者，例如主动隐瞒真实的研究目的，或故意提供一些错误信息以观察研究参与者的反应。伦理委员会在审查时一般会要求研究者证明：研究确实有科学、教育或社会层面的价值；没有其他可行的方法实现研究目的；研究会对研究参与者有直接或间接的潜在获益；研究参与者的尊严和其他权益得到了足够的保护；当欺瞒的途径无法避免时，研究者最好在资料搜集完后，立即向研究参与者说明，最迟不得晚于研究结束时。任何欺瞒均不得导致不可逆的伤害。

（3）干细胞临床研究伦理审查的主要内容

第一，干细胞的来源和获取过程应符合伦理。用于研究的人胚胎干细胞只能通过下列方式获得：体外受精时多余的配子或囊胚；自然或自愿选择流产的胎儿细胞；体细胞核移植技术所获得的囊胚和单性分裂囊胚；自愿捐献的生殖细胞。利用体外受精、体细胞核移植、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚，其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过 14 天，且不得将其植入人或任何其他动物的生殖系统；不得将人的生殖细胞与其他物种的生殖细胞结合。

第二，应采取有效的风险管控措施。参与研究的机构和研究负责人、研究者的资质符合相关技术标准和规范。研究的科学依据充足、研究目的符合伦理、研究设计已通过科学评审，研究结果的用途明确。研究是否对研究参与者进行干预，是否增加研究参与者的额外负担，是否采取了预防措施，是否涉及子宫中胎儿、无法成活的胎儿/流产的胎儿、儿童、孕妇/哺乳期妇女等脆弱群体。对于风险较高的项目，设置重点监控措施，购买相关保险，对发生与研究相关的损害提供治疗及相应赔偿。

第三，应公平公正招募和筛选研究参与者。有明确的纳排标准和筛选流程，招募中明确告知研究名称、申办方或研究单位与研究者信息，研究目的、研究性质及简要的纳入和排除标准。

第四，应做好知情同意。干细胞临床研究人员用通俗、清晰、准确的语言告知研究参与者干细胞临床研究的目的、意义和内容，预期获益和潜在风险，研究参与者自愿签署知情同意书。

第五，应及时报告严重不良事件。在 24 小时内上报严重不良事件，如传染病、造成人体功能或器官永久性损伤、威胁生命、死亡，或必须接受医疗抢救的情况；在发生严重不良事件后应当立刻停止临床研究，并及时、妥善对研究参与者进行相应处理；从干细胞制剂的制备和质量控制，干细胞供者的筛查记录、测试结果，以及任何违背操作规范的事件等方面说明严重不良事件发生的原因和采取的措施，并在处理结束后 15 日上报。

第六，应保护研究参与者的隐私，做好研究保密工作。对研究涉及的个人隐私，详细说明将如何使用代码、加密或其他方式保护研究参与者的隐私；规定获得原始数据或研究记录的人员及其权限；研究完成后，说明如何处理原始数据；说明在论文报告中不公开研究参与者的敏感个人信息。

第七，应做好研究参与者的随访与监测。干细胞临床研究结束后，制订明确的计划对研究参与者进行长期随访监测，并对发现的问题进行评估上报，以评价干细胞临床研究的长期安全性和有效性。

2. 动物实验伦理审查的主要内容　动物实验伦理审查的宗旨在于保护实验动物福利，审查主要内容如下。

（1）参与动物实验人员的资格，包括个人健康状况、曾经参与动物实验的经历与相关培训和技术资质、参与动物实验的时间。

（2）动物实验中使用动物的种属、品系、年龄、性别、动物数量及动物来源的合理理由；尤其对使用动物的数量，应从科学角度和统计学意义方面说明使用动物的科学性与合理性，并提供文献资料证明。

（3）动物实验方法上尽量采用较温和、较不具侵害性的操作；或在满足实验目的的情况下，尽量

使用低等动物、分离的器官、细胞或组织培养或计算机仿真模式替代。

（4）对动物实验过程中的操作程序给实验动物带来疼痛和应激程度进行评估，采用麻醉剂、镇静剂等方法预防与减轻疼痛或应激反应的措施，或采用更好的方法来避免疼痛或应激。

（5）动物实验方案中涉及存活或非存活性手术操作，术中需进行镇静、镇痛及麻醉程序，设计合理的镇痛剂和麻醉剂种类、剂量、给药途径和给药频率；应尽可能减少实验动物的不适、痛苦和应激反应；保定器具应结构合理、规格适宜、坚固耐用、安全卫生、便于操作。在不影响动物实验的前提下，对实验动物身体的强制性限制应减少到最低程度；设置仁慈终点，在不影响动物实验结果的前提下，尽可能减少实验动物承受痛苦和应激的时间。

（6）动物实验方案中如果涉及危险性或感染性试剂，如放射性物质、致癌物/致突变物、感染物质、重组 DNA、肿瘤等细胞系、组织或抗血清以及其他有害物质，必须标明具体试剂名称、拟使用剂量、给药途径及给药频率，并详细描述对人或实验动物的潜在毒性，并简述安全操作和处理受污染动物及材料的方法及程序，保证对实验人员、实验动物以及周边人畜实行恰当充足的保护措施。

（7）实验动物饲养过程中饲养环境、饲养方式应符合相关规范要求，饲养人员不得有戏弄或虐待实验动物的行为，应根据动物食性和营养需要，给予足够的饲料和清洁的饮水；新进实验动物在使用前应给予一段时间的适应性饲养；健康的和患病的实验动物应有效地隔离；充分满足实验动物在妊娠期、哺乳期、不同的实验期、术后恢复期对营养的特殊需要；在因实验需要，不得不对实验动物饮食进行限制时，应有充分的科学理由和必要性说明。

（8）动物实验结束后处死实验动物时应按照安乐死的标准选择合适的安死术，一般情况下不推荐颈椎脱臼安乐死，如必须使用，应给出合理的理由；对于二氧化碳、麻醉过量和麻醉后放血处死等方法，需详细说明麻醉剂名称、使用剂量、频率和给药途径，以尽量缩短死亡过程、减少动物的痛苦。

（9）废弃物与尸体的处理方式应符合相关法规和技术规范要求。

（二）医疗技术临床应用伦理审查的主要内容

1. 人体器官捐献和移植伦理审查的主要内容　开展人体器官获取与移植的医疗机构负责本单位的人体器官捐献和移植伦理审查工作，包括遗体器官获取伦理审查、活体器官获取伦理审查。

（1）遗体器官获取伦理审查应当对下列事项进行审查：①自愿无偿捐献遗体器官的书面意愿是否真实，如是否存在组织或个人强迫、欺骗或利诱他人捐献人体器官的情况。②遗体器官捐献相关知情同意书是否符合法律法规的规定，如已逝世公民的器官捐献是否有法律效力的遗嘱；已逝世公民生前未表示不同意的，其器官捐献决定是否获得了该公民配偶、成年子女、父母的共同授权。③有无买卖或者变相买卖遗体器官及跨服务区转运潜在遗体器官捐献人的情形。④遗体器官捐献人及捐献器官医学评估情况。如审查相关临床医学评估报告及其真实性。

（2）活体器官获取伦理审查应当对下列事项进行审查：①活体器官捐献意愿是否真实，如伦理委员会可通过单独谈话了解器官捐献人的真实动机，告知其可以随时中止捐献行为，对其放弃捐献的原因予以保密，并在必要时设置一定时间的冷静期，防止其作出有违自身真实意愿的选择。②有无买卖或者变相买卖活体器官的情形，如审查是否存在以所谓营养费、误工费或劳务、实物相抵等形式变相买卖器官的情形。③活体器官接受人是否为捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲。查验相关材料的真实性，如审查活体器官捐献人、接受人双方合法身份证明文件和反映其亲属关系的户籍证明或司法部门认可的亲属关系证明，活体器官捐献人无偿捐献器官的书面材料，获取活体器官和器官移植手术风险及其术后并发症知情同意书，活体器官捐献人健康及风险评估情况，活体器官获取必要性、适应证评估及配型情况，伦理委员会认为需要提供的其他相关材料。④活体器官的配型和移植接受人的适应证是否符合人体器官移植技术临床应用相关技术规范。⑤活体器官捐献人的健康和心理状态是否适宜捐献器官。

2. 生殖医学伦理审查的主要内容　我国《人类辅助生殖技术管理办法》《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》《产前诊断技术管理办法》等部门规章和指导性文件对医疗机构开展安全、有

效、合理、规范的人类辅助生殖和人类精子库技术、产前诊断技术提出了伦理审查要求。针对上述技术临床应用的特点，目前生殖医学伦理审查的主要内容包括以下几个方面。

（1）医疗卫生机构和医务人员的资质证明，如机构和人员的资质、经验是否满足技术开展的需要，人员配备及设备条件等是否符合临床技术标准要求。

（2）技术方案路线是否适当，包括技术目的、技术方法、检查方式是否会使患者及其后代等利益相关者受到潜在风险或伤害，风险获益比是否合理，技术应用是否具有科学性、准确性和合法性。

（3）知情同意书的信息资料是否科学准确、完整易懂，获取知情同意的过程是否适当。如辅助生殖技术的信息告知主要包括：所选辅助生殖技术的必要性、替代治疗/其他选择、治疗程序、本机构稳定的成功率、潜在的获益、每周期大概治疗费用及进口或国产药物的选择、短期和长期的潜在身体和心理上的风险（包括多胎的风险、异常怀孕、自然流产和对未来后代的任何不利结果等）以及为降低这些风险所采取的措施；治疗过程中医师和患者的义务和责任，包括后代享有的法定权利和义务；夫妇双方可随时中止辅助生殖治疗，并且不会对其今后的治疗产生影响；对夫妇及出生后代进行长期随访和评估的必要性。产前诊断技术的信息告知主要包括：产前筛查疾病范围和胎儿畸形的疾病分类；产前诊断疾病信息及其可能的危害，使孕妇或家属理解技术可能存在的风险和结果的不确定性；现实案例中相同或类似疾病的风险判断和处置；产前诊断意见出具的流程和注意事项；在发现胎儿异常或出生缺陷的情况下，继续妊娠和终止妊娠可能出现的结果以及进一步处理意见；社会救助体系及相关机构信息等。

（4）夫妇双方个人信息及相关资料的保密措施是否符合要求。

（5）技术实施涉及的利益冲突和社会舆论风险。

（6）生殖医学伦理委员会伦理审查要求提供的其他资料和信息。

3. 医疗新技术临床应用伦理审查的主要内容

（1）科室和人员资质：医疗新技术应用负责人和操作人员简介和技术资质，科室相关诊疗场所、设备、设施、其他辅助条件和辅助支持科室情况。

（2）医疗新技术实施方案：开展新技术临床应用的目的、意义和依据，新技术在国内外的应用现状及领先水平；与同种疾病其他诊疗技术的风险、费用及疗程比较；具体操作方法和步骤；新技术的适应证、禁忌证和不良反应；安全性检查和检验指标等。

（3）知情同意：知情同意书通俗易懂，内容全面，包括：本机构和相关人员开展此项新技术的资质；新技术目前的安全性和疗效评价；对患者的预期风险与获益；新技术应用的适应证、禁忌证和不良反应；可替代的治疗方案；治疗费用和相关收费标准；发生严重不良反应后的治疗及相关赔偿。

（4）应急预案：不良事件监控制度，包括不良事件的上报制度、应急预案和处理措施。

（5）随访与监测：随访与监测制度，依据治疗例数、治愈好转率、死亡例数、病死率、1年生存率、5年生存率等评估指标，对医疗新技术进行定期跟踪随访，了解其对疗效、生存质量的评价，患者心理上的感受，以及对其家庭和社会生活的影响等。

四、医学伦理审查的监督管理

医学伦理委员会的伦理审查工作需要接受国家、地方、相关行业主管部门的管理、指导和监督。对不同责任主体在科技活动中违反科技伦理规范、违背科技伦理要求的行为，任何单位或个人有权依法向科技活动承担单位或地方、相关行业主管部门投诉举报。

若医学科技活动承担单位、科技人员存在以弄虚作假方式获得伦理审查批准，或者伪造、篡改伦理审查批准文件；未按照规定擅自开展需要伦理审查和专家复核清单管理的科技活动；超出伦理审查批准范围开展科技活动；干扰、阻碍伦理审查工作等违规行为，由有管辖权的机构依据法律、行政法规和相关规定给予处罚或者处理；造成财产损失或者其他损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

若医学伦理委员会、委员存在为科技活动承担单位获得伦理审查批准提供便利，徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守等违规行为，也应受到同样处罚。

高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业等是科技伦理违规行为单位内部调查处理的第一责任主体，若单位或其负责人涉嫌科技伦理违规行为，由其上级主管部门调查处理，没有上级主管部门的，由其所在地的省级科技主管部门负责组织调查处理。

思考题

1. 我国法规中对医学伦理委员会的组成和职能有哪些要求？
2. 涉及人的生命科学与医学研究伦理审查的主要内容是什么？
3. 如何遵循“五大自由”和“3R”原则开展动物伦理审查？
4. 医学伦理审查有哪些程序？

（杨　阳）

第十五章 医院管理与卫生政策伦理

本章数字资源

当今世界，国民健康已经成为衡量一个国家社会进步的重要标志之一。与此相适应，世界各国也越来越重视对卫生事业的改革和管理研究，其中，医院管理、卫生保健制度、医药卫生体制改革是卫生事业管理中的核心内容。我国的卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业，卫生事业发展不仅涉及政治和经济，也涉及民生和伦理问题。当前，卫生事业发展面临的主要问题是人民群众的巨大需求和资源有限性之间的矛盾，它决定了在卫生事业的制度设计、目标实现和现实运行中都无法回避伦理道德的审视。

第一节 | 医院管理伦理

医院是依法定程序设立的从事疾病诊断、治疗、预防、保健活动与紧急救治各类疾病患者并设立住院床位的医疗场所，是维护人民健康的主体。不断提高医疗服务质量，为人民群众提供安全、适宜、优质、高效的医疗卫生服务，是国家和社会对医院的基本要求；而加强医院管理伦理建设，是提升医院服务质量的重要保障。

一、医院管理的概念

（一）医院管理的含义

管理是人类社会的客观需要，管理活动是人类各种活动中最重要的活动之一，它广泛存在于人类社会活动之中。所谓医院管理（hospital management），是指为了有效地实现组织目标，按照医院工作的客观规律，由管理者运用相关知识、技术和方法，对医院活动进行决策、组织、领导、控制并不断创新的过程。

在实践中，对医院管理的理解一般有狭义和广义之分，狭义的医院管理主要是指医院医疗服务的流程管理。其主要任务是，通过科学的组织、计划与控制，使医疗过程的诸要素——医务人员、医疗技术、医疗设备、医疗物资和医疗信息得到合理的结合，以提高工作效率，提高医疗质量和技术经济效果。其内容包括人力资源管理、门诊管理、住院诊疗管理、护理管理、药事管理、病案管理、质量管理，等等。而广义的医院管理，除包括对疾病诊断、治疗和康复外，还关注医院的医疗服务和宏观社会关系，更多的是从全院组织管理和健康照顾服务体系的视角来界定管理内容，如医院组织管理、医院预防保健与社区卫生服务管理、医院宏观管理等。

（二）医院管理的特征

1. 医院管理的目的是有效地实现医院预定的目标 管理本身不是目的，管理是为医院目标的有效实现服务的。医院是由各个部门组成的一种特定的社会组织，也是具有独立法人资格的经济实体。医院这种特殊的行业性质决定了医院活动的双重功能，既要为社会公众的健康提供优质的医疗服务，同时在市场经济体制下，也要为医院自身的生存和发展谋求一定的经济利益。为了协调好医院的正常运转，必须进行一定形式的管理。

2. 医院管理的主体是具有专门知识、利用专门技术和方法来进行专门活动的管理者 医院是以诊疗疾病、照护患者为主要目的的医疗机构，是一个专业技术强、科技含量高、安全要求严、部门繁多、流程交错、各类人员密集、庞大而复杂的系统，面对这样一个特殊的社会组织和高科技的维护生命健

康的专业活动，对管理者的知识、能力和素质的要求是不一样的。

3. 医院管理的客体是医院活动及其参与要素　医院需要通过特定的活动来实现其目标，活动的过程是不同资源的消耗和利用的过程。为促进医院目标的有效实现，管理需要研究怎样充分地利用各种资源，如何合理地安排组织的目标活动。

4. 医院管理是一个包括多阶段、多项工作的综合过程　决策虽然在管理劳动中占有十分重要的地位，但是管理不仅是决策。管理者制定了正确的决策后，还要组织决策的实施，激发医院成员的工作热情，追踪决策的执行进展，并根据内外环境的变化进行决策调整。因此，医院管理是一个包括决策、组织、领导、控制以及创新等一系列工作的综合过程。

二、医院管理中的伦理问题

（一）社会效益与经济收益之间的协调问题

医院作为卫生服务体系的重要组成部分，坚持为人民健康服务的宗旨，体现了国家卫生事业的公益性和保障性，同时，作为独立的法人实体，医院还具有生产性和经营性的特点。

医院的双重属性，决定了在医院的管理中，必须正确处理经济收益和社会效益之间的关系问题。从根本上说，社会效益与经济收益是一致的。但在现实中，医院的社会效益和经济收益之间的矛盾已经成为医院管理伦理中一个突出的问题，其突出表现是公立医院的逐利行为愈发明显，公益属性逐渐淡化。具体表现在以下几个方面。

1. 公立医院医疗行为的过分市场化　20 世纪 90 年代中后期以来，我国对公立医院推行自主化改革，从全额预算拨款单位转变为差额预算拨款单位，公立医院走向自主经营、自负盈亏的发展道路。政府投入不足迫使部分公立医院将医疗公益化推向了市场化。医院管理者为了医院的发展和医护员工的收入，为了追求经济收益，将医护人员的收入直接与处方挂钩，采用过度检查、过度开药等过度诊疗做法，将医疗药品和设备的购置成本直接转嫁给患者，损害了广大百姓的利益，造成了医患关系紧张的局面。

2. 重治疗、轻预防　新中国不同时期的卫生工作方针都明确指出卫生工作应以预防为主，但出于对经济收益的盲目追求，我国医院往往倾向于重视对疾病的治疗而忽视预防工作。疾病预防工作严重滞后于人民群众的健康需要，许多医疗机构并未主动采取措施提高辖区人民群众的防病、抗病能力，而是被动接收并治疗到医院求诊的患者，或在治疗过程中为提高医院或个人经济收益而进行过度诊疗，盲目趋利，加重了群众的看病就医负担，造成了不好的就医体验，有损医院及医务人员的社会形象。

3. 公立医院规模的盲目扩张　部分公立医院大规模扩张带来了巨大的债务压力，在财政补助难以增加的情况下，医院只能通过自我创收来解决这个问题。但患者的医疗需求不会随着公立医院规模的扩张而快速增加，同时公立医院在医疗服务的定价上面临着严格的价格管制，不允许其随意定价。有些公立医院通过诱导需求的方式，刺激需求短时间内快速增加，以提高医院的医疗收入。这一做法既造成卫生资源的极大浪费，也造成消费者不应有的经济损失；既扭曲了医院的公益性质，也损害了公众对医务人员的信任。

（二）医联体伦理

1. 医联体建设情况　医联体即区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，在三级医院、二级医院与社区卫生服务中心之间加强联合。逐步建立完善不同级别、不同类别医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，推动构建分级诊疗制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。

当前我国主流的医联体模式主要有城市医疗集团、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网四种。

城市医疗集团是指在市级城市由一所三级医院联合若干二级医院和社区卫生服务中心组成的跨行政隶属关系、跨资产所属关系的医联体。城市医疗集团的优势是能够调整并优化医疗资源布局，促

进医疗卫生资源下沉，提高基层服务能力，壮大基层队伍。

县域医共体是一种以管理和资产为纽带组成的紧密型医联体，该医疗服务体系以县医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础。县域医共体是连接基层医疗服务和城市优质医疗资源的重要纽带，在夯实县域基础、提升基层卫生服务能力方面起着关键性作用。

专科联盟指的是以一所特色专科医疗机构为主，通过协议或契约方式与其他同类专科机构建立起协作经营关系，促进各医疗机构之间的业务协作、分级诊疗的模式。

远程医疗协作是指医疗机构利用计算机技术开展的异地、交互式的指导、检查、诊断、治疗等医疗会诊活动的行为。

2. 医联体运行中的伦理问题　医联体建设的推行符合我国国情，它与卫生事业发展的现实需求相符，有利于优化卫生资源配置，能够促进卫生资源合理利用，是整合医疗卫生服务体系构建的必然趋势。但在运行过程中，也出现了一系列的问题，如各地城市医疗集团建设过程中，存在法人治理机制不明确、利益分配机制不清晰、优质资源下沉不完全等问题。部分医疗集团的组织形式较为松散，未能形成利益和责任相关体，各个医疗机构管理体制和目标不同，会导致沟通效率低、协调难度大等问题。具体包括以下几点。

（1）县域医共体内部统一配置人力资源、提供较为有效的政策支持，但是基层医务人员往往没有制度性的上升通道；在薪酬制度方面，医共体对结余资金并不能够完全自主留用；此外，医保基金管理方式的制度细节设定十分关键，如“总额预付”与“总额预算”，“超支合理分担”与“合理超支分担”等，这些政策表述实质存在重要差异。

（2）专科联盟应不破坏各医院原有的体制和机制，因而可能会出现联盟组织松散、成员间工作信息系统不兼容等问题。联盟内部利益的分享机制与风险的分担机制不完善，各成员之间的“责权利”关系尚处于摸索中，针对医联体的具体医保政策不够详细，这也是影响专科联盟发展的重要因素。

（3）远程医疗协作网受援地区网络通信等基础设施覆盖、普及率较低，相关技术规范尚未形成；远程医疗服务分类标准不一致，无法统一管理；远程急救技术亟待完善；法律法规及监管体系欠缺，网络信息安全管理制度还有很多不足；等等。

（三）分级诊疗伦理

1. 分级诊疗制度的基本情况　分级诊疗（hierarchical medical system），是指通过对各层级医疗机构进行功能划分，根据疾病的轻重缓急选择不同层级医院诊治，优化医疗资源的合理配置，营造良好就医环境，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

建立分级诊疗制度，是合理配置医疗卫生资源、切实推进基本医疗卫生服务公平可及的重要举措。为加快建立分级诊疗制度，国家陆续推进国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置和布局建设，集中力量开展疑难危重症诊治技术攻关。省级区域医疗中心建设有序开展。同时，提升市级和县级医院专科能力。聚焦重点病种和专科，布局省级区域医疗中心，缩小地市重点疾病诊疗水平与省会城市的差距。另外，加大城市医院对口支援力度，持续推进县级医院专科建设，补齐短板弱项。加强乡镇卫生院和社区卫生服务机构建设，发展社区医院，深入开展“优质服务基层行”等活动，双向转诊机制得到优化。

2. 分级诊疗制度推行中的伦理问题

（1）医疗资源配置的公平问题：我国人口众多，且整体卫生资源有限，导致基层医院和三级医院、发达城市和偏远农村地区的医疗资源分配存在显著差异。分级诊疗制度建设过程中，政府开始逐步加大对农村乡镇卫生院的财政支持力度，基层医疗机构资源配置情况有所改善。但是，如果政府支持不能持久，农村乡镇卫生院将回到经营困难的老路。农村乡镇卫生院的人员水平不足，难以适应医疗服务的需要。

（2）对患者的尊重问题：分级诊疗模式应尊重患者在首诊、转诊过程中的知情选择权，满足社会多样化的医疗卫生需求。但在分级诊疗中，存在诸多不够尊重患者知情选择权的现象。例如，由于宣

传教育方面的不到位，患者对医疗机构的功能和服务可能并不了解，无法做到知情选择；在临床治疗中，由于医患沟通时间短暂等因素，医师可能并未向患者提供足够的转诊信息等。

（3）分级诊疗的效率问题：管理体系和衔接机制的不顺畅，导致分级诊疗制度中的“上下联动”没有很好地落实。在政府层面，各级医疗卫生机构设置存在上下部门工作协调不顺畅等问题。相关行政部门改革政策和监督实施的权力分散。医院之间的联系不规范。各地试点形式多样，有院办院管形式，有对口支援形式，没有形成统一制度、机制和考核标准。

（4）患者对医疗卫生机构的信任问题：随着人们的生活水平提高，对健康的重视程度也在不断加强，由于各级医疗卫生机构报销比例之间差别甚小，二、三级医疗卫生机构的医疗资源和就医环境相对于基层医疗卫生机构更好，所以患者更愿意选择就医环境好的医疗机构就医。各级医疗卫生机构之间协作较弱，存在着检查结果互不认可的现象。

三、医院管理伦理要求

（一）以患者为中心

“以患者为中心”，是指医院管理者在管理过程中，从维护患者利益出发，将为患者服务、满足患者合理的医疗卫生需求作为医院各项工作的中心，把患者至上、一切为了患者的伦理要求落实到具体的管理措施中。

“以患者为中心的医疗服务”理念最早由美国提出，1996 年，世界卫生组织发布题为《迎接 21 世纪的挑战》的报告，指出 21 世纪的医学将由“以疾病为中心”向“以患者为中心”（patient-centered）发展。在我国，“以患者为中心”的医疗服务理念始终贯穿医药卫生体制改革进程。1996 年，全国卫生工作会议提出，把“以患者为中心”作为我国医院的办院宗旨，推动“以患者为中心”理念在全国范围内推广。2005 年 4 月，卫生部等在全国开展医院管理年活动，促进各类医院端正办院方向，牢固树立“以患者为中心”的服务理念。2021 年国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，强调要强化患者需求导向，坚守纯粹医者信念。在一系列政策的引导下，我国逐步朝着“以患者为中心”医疗服务模式发展。

在医院管理中，“以患者为中心”主要体现在医院制度文化建设和导向上，要强化引导和支持医务人员开展“以患者为中心”诊疗行为。在坚持“以人为本”管理理念的同时，关注患者就医体验。将患者导向纳入医院发展战略规划，在建设医院自身特色组织文化内核中深度嵌入患者导向的服务理念，通过组织文化建设推动医院、医师和患者利益紧密结合，纠正医师只重技术不重服务的错误认识，引导医师树立正确的患者导向理念。要引导医务工作者强化患者需求导向。坚守纯粹医者信念，尊重医学科学规律，遵守医学伦理道德，遵循临床诊疗技术规范，为人民群众提供安全、适宜、优质、高效的医疗卫生服务。要持续改善医疗服务，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，开展诊间（床旁）结算、检查检验结果互认等服务。加大健康教育和宣传力度，做好医患沟通交流，增进理解与信任，为构建和谐医患关系营造良好社会氛围。

（二）以医务人员为本

“以医务人员为本”是指以医务人员为中心，强化医务人员的主体地位，强调人是目的的理念，将其作为医院发展的重要对象，强调对医务人员的尊重、关心与理解。

广大医务人员是医院管理的客体，也是医院工作的主体，是医疗服务的实践者和直接提供者。医院开展工作，没有广大医务人员的积极参与，终将成为空谈。“以医务人员为本”是“以人为本”的原则在医院管理中的具体体现，要求医院管理者重视医务人员的价值，维护其尊严和权利，以调动医务人员的积极性、做好医务人员的服务为根本。

医院管理者要树立“以医务人员为本”的管理理念，全面落实人本管理思想，实现人性化管理，为员工排忧解难，保证广大医务人员的利益不受损害。要改革薪酬分配制度。落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于

人员奖励”要求。建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系。医院要设立体现医疗行业特点、劳动特点和岗位价值的薪酬项目，充分发挥各项目的保障和激励作用。

要建立保护关心爱护医务人员的长效机制。改善医务人员的工作环境和条件，减轻工作负荷，落实学习、工作、休息和带薪休假制度，维护医务人员的合法权益。鼓励公立医院通过设立青年学习基金等多种方式，关心年轻医务人员的成长。健全职工关爱帮扶机制，切实解决医务人员的实际困难。建立医务人员职业荣誉制度。加强医院安全防范，强化安保队伍建设，完善必要安检设施。将解决医疗纠纷纳入法治轨道，健全完善医疗纠纷预防和处理机制，依法严厉打击医闹、暴力伤医等涉医违法犯罪行为，坚决保护医务人员的安全。

（三）服务质量至上

医疗服务质量（medical service quality）是指医院所提供的医疗服务能够满足患者规定和潜在需求的特征和特性的总和，即服务工作能够满足被服务者需求的程度。服务质量不但影响患者的就医体验，而且事关医院的声誉和效益，决定医院的生存和发展。

医疗服务质量的优劣，主要取决于广大医务人员的技术水平和医德水准。医院管理者要注意挖掘整理医院历史、文化特色和名医大家学术思想、高尚医德，提炼医院院训、愿景、使命，凝聚支撑医院高质量发展的精神力量。大力弘扬崇高职业精神，激发医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的不竭动力。

要整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，建立医院运营管理决策支持系统，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化。以大数据方法建立病种组合标准体系，形成疾病严重程度与资源消耗在每一个病组的量化治疗标准、药品标准和耗材标准等，对医院病例组合指数（case mix index，CMI）、成本产出、医师绩效等进行监测评价，引导医院回归功能定位，提高效率、节约费用，减轻患者就医负担。

要坚持和强化公益性导向，全面开展公立医院绩效考核，持续优化绩效考核指标体系，重点考核医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等。要改革公立医院内部绩效考核办法，以聘用合同为依据，以岗位职责完成情况为重点，将考核结果与薪酬分配挂钩，进一步强化广大医务工作者的质量意识，严把医疗质量关，以优质的服务质量赢得患者的信任和认可。

（四）将社会效益置于首位

医院工作效益包含社会效益和经济收益。其中的社会效益是指医院在防病、治病中对保护社会劳动力、提高群众健康水平以及维护社会稳定方面所作出的贡献。

医院管理应将社会效益放在首位，主要是由医院的公益属性所决定的。公益性（public welfare）是指使社会公众受益的性质。《医疗机构管理条例》规定，医疗机构以救死扶伤，防病治病，为公民的健康服务为宗旨。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》规定，医疗卫生与健康事业应当坚持以人民为中心，为人民健康服务。医疗卫生事业应当坚持公益性原则。同时明确，政府举办的医疗卫生机构应当坚持公益性质，所有收支均纳入预算管理，按照医疗卫生服务体系规划合理设置并控制规模。正是卫生事业的社会公益性决定了医院的公益性。医院还是具有生产和经营属性的单位。医院的主要产品是提供医疗服务，通过一系列的医疗、预防、保健及康复活动，使患者恢复健康，延续生命，这是社会劳动力的维护和再生产活动。医疗活动需要人力、物力和财力的投入，必须讲究投入与产出的关系。这就要求医院既要遵循医疗工作的内在规律和要求，又要遵循市场规律，获得一定的经济收益。

医院工作必须兼顾社会效益与经济收益，在观念上不可将二者对立起来。合理的医疗经济收益也是发挥医院社会责任和体现其道德价值的基础。医院管理要适应市场经济和新时代中国特色社会主义的发展要求，注重经营质量，但必须坚持以社会效益为最高准则，杜绝因追求经济收益而忽视质量管理和社会效益的错误做法。医院管理如能够处处为患者利益考虑，提高医疗质量，改善服务态度，必定会促进医院运营效率，从而带动较好的经济收益。好的经济收益当然可以吸引更优秀的医疗人才，也可用来改善医院环境及设备设施，从而保障医院治病救人的使命得以有效落实。

第二节 | 卫生保健制度伦理

卫生保健制度是一个国家社会制度的重要组成部分，是多种因素的产物。它与一个国家或地区的社会经济制度、经济发展水平和财政实力、卫生服务组织的状况等因素密切相关，并随着这些因素的变化而变化。构建何种卫生保健制度以达到既能够平衡社会各方面利益，又能满足社会成员不断增长的健康保障需求，成为世界各国必须关注的重要议题。

一、卫生保健制度概述

（一）卫生保健制度的含义

卫生保健制度（health care system）是指一个国家或地区为解决居民防治疾病问题而筹集、分配和使用医疗卫生保健费用而采取的一系列综合措施。卫生保健制度与医疗保健制度、医疗保险制度、健康保险制度、健康保健制度、疾病保险制度等基本上属于同义的概念，是不同学科或不同情形下的特定表述方式。它是一个国家的政治、经济和文化特征的总体反映，也是政府及其政党对国家卫生事业的政策导向的体现。

社会所能提供的医疗卫生资源总是有限的，而人们的医疗卫生需求却是无限的。为了保证有限资源在不同社会成员之间以及不同医疗卫生需求之间进行公平分配，以达到卫生保健制度的目标，必须采取筹集、分配和使用医疗卫生保健费用的综合措施，即建立卫生保健制度。

（二）卫生保健制度的构成和分类

完整的社会卫生保健制度，至少包括四个主要构成部分，即医疗财政制度（healthcare financing system）（包括筹资和支付）、医疗提供制度（healthcare delivery system）、医疗产业制度（health-related industries system）和公共健康制度（public health system）。这四个子系统紧密相关、相互影响、博弈共存并综合作用，以一种极为复杂的结构构成完整的卫生保健制度系统，即医药卫生体制。

对卫生保健制度的划分，一般采取综合分类法，依据是国家的经济制度和经济发展水平、卫生保健的管理体制、费用的筹集和支付方式等。国际现存卫生保健制度模式主要有国家卫生保健制度模式、社会医疗保险模式、商业医疗保险模式、储蓄医疗保险模式、社区医疗保险模式。

二、卫生保健制度中的核心伦理价值

（一）改善质量

改善质量是卫生保健制度的重要伦理价值取向，主要包括：改善人口的健康状况和注重卫生保健制度的反应性两个方面。

1. 改善人口的健康状况　健康权是公民最基本的权利，1978 年世界卫生组织在《阿拉木图宣言》中强调了政府的健康责任，提出政府有责任提供适宜的技术与方法促进公民健康。可以说获得最高质量的健康是全世界共同追求的目标。一个国家建立卫生保健制度，其根本目标就是为了最大限度地保持和促进民众的健康，其测量目标主要包括“人口的健康状况”“卫生保健制度的反应性”和“筹资的公平性”三个方面。

2. 注重卫生系统的反应性　卫生系统在多大程度上满足了人们对其在改善健康方面的普遍的、合理的期望，成为从服务质量角度评价卫生绩效的重要指标。它一般包括“对患者的尊重”和“以患者为中心”两个方面。

（1）对患者的尊重：包括尊严、自主性和保密性三个方面。尊严（dignity）是指患者在接受卫生服务时应该受到尊重，患者的身体隐私应该受到保护，应该保护特殊患者的人权。自主性（autonomy）是指在诊疗时，卫生服务的提供者应该尊重患者的知情同意权；卫生服务的提供者应该尽可能提供多种可供选择的诊疗方案，告知每个方案的利弊，并提出医务人员的建议，以便于患者选择。保密性

(confidentiality)是指卫生服务的提供者应该为患者在接受卫生服务时的有关隐私情况保密;卫生服务的提供者应该对与患者交谈的情况保密。

(2)以患者为中心:包括及时关注、社会支持网络、基本设施质量和卫生服务提供者的选择性四个方面。及时关注(prompt attention)是指从患者住宅到卫生保健机构的距离应该足够短,到达不需花费太长时间;急诊服务应该及时;患者有权在合理的时间内获得诊治,包括非急诊治疗和手术,候诊时间要短;患者在医疗机构等候咨询和实验室检查的时间不应该太长。社会支持网络(social support networks)是指允许患者亲戚、朋友进行探视;允许亲戚、朋友提供食品或其他礼品等。基本设施质量(quality of basic amenities)是指清洁的环境;足够的家具;卫生营养的食品;良好的通风条件;清洁的饮用水;清洁的厕所;干净的被褥以及医疗卫生机构建筑和设施的维护等。卫生服务提供者(choice of health providers)的选择性是指自主选择医疗卫生机构;有权选择卫生服务提供者;可以对卫生服务提供者进行二次选择;患者有选择专家的权利。

(二)体现公平

体现公平是卫生保健制度的灵魂。卫生保健制度中的公平是指经济公平和社会公平在医疗卫生制度建构、实施、运行中的具体体现。主要包括医疗卫生筹资的公平、医疗卫生服务提供的公平、医疗卫生利用的公平和医疗卫生产出的公平四个方面。

1. 医疗卫生筹资的公平　又称支付能力原则,是指个人或家庭对医疗卫生服务的投入,应当按照其收入水平和支付能力而定,而不是按照其获得的服务成本来确定。医疗卫生服务筹资的公平包括水平公平和垂直公平。水平公平是指具有相同支付能力的人应支付相同的费用,垂直公平是指具有不同支付能力的人支付的卫生费用不同,支付能力高的人应该支付更多的费用,支付能力低的人则可以负担较少的费用。

2. 医疗卫生服务提供的公平　是指卫生保健制度为民众提供合理的卫生服务,具体包括如下两个方面。

(1)医疗卫生资源配置的公平:使构成卫生资源的各要素形成合理的组合,这种组合使得卫生资源能够得到充分有效地利用,使该地区的居民能得到所应得到的卫生服务。这里的卫生资源是指用于提供卫生服务的人、财、物,即主要是指硬性卫生资源。尤其值得重视的是高、精、尖和大型先进医疗设备的公平配置,包括人口分布公平性和地理分布公平性。

(2)医疗卫生服务的可及性公平:所谓医疗卫生服务的可及(accessibility)是指服务对象寻求且获得服务的难易程度。可及性公平要求考虑服务对象是否确实能方便、及时和实际地获得负担得起的和可接受的服务。狭义的医疗卫生服务的可及性公平,主要是指地理距离方面的可及性,即民众如果有医疗卫生服务的需求,是否可以公平地在一定区域中及时地得到相应的卫生服务。

3. 医疗卫生利用的公平　又称医疗卫生需要/需求的公平,是指有同等医疗卫生保健服务需要的社会成员,能获得同样的医疗卫生服务,而有更大卫生保健服务需要的社会成员,应能获得更多的服务。医疗卫生服务利用的公平同样包括横向公平和纵向公平:横向公平主要是指具有相同的卫生服务需要的人群,应该获得相同的卫生服务利用。纵向公平是指具有不同卫生服务需要的人群,应该获得不同的卫生服务利用,或者对于不同健康状况的个体需要提供不同的卫生服务。

4. 医疗卫生产出的公平　即健康公平性或卫生服务的健康公平,也称结果/结局方面的公平,就是指不同社会人群的健康水平相等或相似,健康状况分布均衡。要求在不同的社会、经济、人口和地理环境的人群间,不存在可以避免的一个或者几个方面的健康差异。

(三)提高效率

卫生保健制度中的效率是指在一定的卫生保健制度设计和实际运行过程中所反映出的投入与产出、成本与效益之比的状况,是卫生服务各项目的成果同花费的人力、物力、财力等之间的比较情况,是所有医疗卫生服务相关制度与卫生服务各要素的适应程度。

效率的根本原则是投入最小而产出最大,卫生保健制度效率的根本原则同样是以最小的医疗卫

生资源投入，取得最大的医疗卫生服务产出。其中医疗卫生资源的投入主要是指资金的投入，而体现卫生系统产出的指标有健康状况、反应性、筹资公平性以及它们的水平和分布等。应该说，卫生保健制度中的效率，就是要在有限的医疗卫生资源下，实现医疗卫生服务系统产出的最优化。它不但包括获得更多的产出，而且要获得更恰当的医疗服务；除了考虑医疗服务的数量和成本之外，还应该重视医疗服务的质量以及在医疗服务整个过程中提供恰当的服务。

当前，卫生保健制度中的效率，一般分为配置效率和技术效率。配置效率是指卫生资源在不同地区或服务项目之间的配置可能达到最大收益的程度。通常评价配置效率的指标有临床利用率、医师日均担负诊疗人次等。

技术效率是指利用最佳的生产要素组合和最佳的管理方式，在一定的资金条件下，生产出最大数量的符合消费者需要的卫生服务。相对于人们的医疗卫生需求，医疗卫生资源总是有限的，因此，应该有效地利用卫生资源，使其能发挥最大的效益。通常用平均医疗费用、平均住院日等指标进行评价。

三、国际上典型卫生保健制度模式的伦理评价

（一）国家卫生保健制度模式

国家卫生保健制度模式（national health service model），又称全民（政府）医疗保险模式、国家税收模式或贝弗里奇模式，是一种福利性模式。这种模式通过征税方式筹集卫生保健费用，卫生服务的费用支付方式或补偿方式有公共集成式和公共契约式两种。两者的代表分别是英国和加拿大。

国家卫生保健制度模式的价值优势表现为公平性好，不仅表现为筹资方面，还表现为制度覆盖方面，体现了国家责任、普遍覆盖、全面受益的特征。但其价值劣势也是非常明显的。一方面，筹资的可持续状况堪忧；另一方面，医疗服务的提供效率和质量往往较低。

由于资金渠道单一，国家的医疗费用负担重；由于全民免费医疗，国家为此要从税收中划拨相当数量的经费。从长远来看，财政压力会越来越大，最终不堪重负，从而影响到这种模式的可持续性。

公共集成式医疗体系由于忽视市场的调节作用，卫生服务效率低下，供不应求的现象较为突出，患者缺乏自主性，转诊看病等待的时间太长，患者合理的医疗需求得不到满足，不少患者为了及时得到治疗只好选择私立医院。医务人员的工作积极性不高，服务质量难以提高，导致高水平医务人员流失，英国为此进行改革和完善。公共契约式的医疗体系往往采用按服务项目补偿的方式，医疗机构提供的服务项目越多，得到的补偿也就越多，很容易诱导需求。

（二）社会医疗保险模式

社会医疗保险模式（social health insurance model）由国家通过立法形式强制实施，卫生保障基金社会统筹、互助共济，主要由雇主与雇员按一定比例缴纳，政府给予一定补贴。德国是典型代表，卫生服务的费用支付方式或补偿方式有公共集成式、公共契约式和患者赔偿式三种。

社会医疗保险模式的价值优势不但表现在有较好的公平性，而且还具有一定的效率和质量优势。在筹资公平方面，通过国家立法进行强制，保险基金由国家、雇主和劳动者共同负担，基金有稳定来源，有利于筹集到更多的卫生保健费用，政府负担相对较轻；而且个人缴费义务与享受健康保险的权利相关，强化了个人的健康责任。在服务公平方面，强调互助共济，实行社会统筹，使疾病风险在参保者之间分担，通过风险共担实现社会再分配功能，有利于促进公平性。在效率和质量方面，通过设计合理的保险方案能够有效控制卫生费用的迅速上涨，管理成本相对较低，医疗保险基金还可以发挥集体购买者的独特作用而提高效率和质量。

社会医疗保险模式的价值劣势表现在实现价值取向存在着许多制约因素。首先，这种模式以就业和有固定收入作为筹资的前提。对于无收入、低收入和非正规就业部门的就业人群，通过社会医疗保险筹资是困难的。其次，医疗保险费用负担的代际转移问题突出，特别是在老龄化程度较高的国家或地区，这个问题更为突出。容易出现逆向选择现象。另外，这种模式由于过分追求互助共济，健康

NOTES

保险如同吃大锅饭，投保人、医院、药房、保险公司等医疗费用意识缺乏，结果是医疗费用增长，保险费率也逐年增加。

（三）储蓄医疗保险模式

储蓄医疗保险模式（medisave model）又被称为保健储蓄医疗保险模式。这种模式通过立法强制设立储蓄医疗基金，把个人消费的一部分以个人公积金的方式储蓄转化为保健基金。目前采用这种模式的代表性国家是新加坡。

储蓄医疗保险模式的价值优势是：首先，强调了个人责任和家庭价值，为筹资公平寻求一种新的途径。这种模式使每个人通过纵向积累，筹集患病时所需医疗费用，有利于代际公平。储蓄以家庭为单位，较好地解决了医疗费用负担的代际转移问题。同时有利于满足不同层次的健康需求。其次，新加坡的范例显示，这种模式的管理效率较高，效果较好。其价值劣势表现在公平性不够完善：在注重代际公平（纵向公平）的同时，没有社会统筹，忽视了社会互助共济、共同分担疾病风险的公平（横向公平）。

（四）商业医疗保险模式

商业医疗保险模式（private health insurance model），也被称为私营医疗保险、自愿医疗保险。这种模式通过商业性自愿医疗保险方式来筹集卫生保健费用。在这种模式中，保险公司自由经营，医疗消费者自愿投保，与社会医疗保险模式最大的不同是，雇主与雇员之间参与医疗保险的规定不是强制的。美国是这种模式的典型代表。

商业医疗保险模式的价值优势在医疗服务的质量和效率方面。每一个人自由投保，多投多保、少投少保，体现了效率原则；医疗保险经营者之间自由竞争，对健康需求反应灵敏，能够“以患者为中心”，满足个体化的医疗需求，从而提高医疗保险费用的效率；医疗机构及其医务人员之间的自由竞争，能够提高医疗服务水平，使医学科技迅猛发展；自由的市场经济体制同样可以为医疗卫生领域吸引更多的资金、人才和技术。

其最大的价值劣势是公平问题：健康保障主要受支付能力的限制，社会公平性较差。一方面，难以实现全民医保。商业医保首先强调风险控制和赢利，这就导致保险公司在选择客户群体和设计保费时考虑了过多的商业因素，这种完全以市场选择为主的体制势必会导致一部分脆弱人群被排除在医保之外。另一方面，不同收入人群享有的保障程度差别过大。另外，医疗费用飞涨。出于营利目的，大量资源投入高水平医疗服务，满足医疗高消费，导致医疗费用的快速增长。巨大的医疗支出牵涉了巨额的利益分配和社会道德问题。

（五）社区医疗保险模式

社区医疗保险模式（community-based health insurance model）是某一社区基于自愿和互惠互利的原则，通过动员该社区成员而筹集、分配和使用卫生保健基金。近年来，这种模式在许多低收入或中等收入国家中发挥着越来越重要的作用。我国20世纪50—60年代兴起的农村合作医疗就属于这种模式。

社区医疗保险模式，针对其目标人群，从一定意义上可以改善预防服务，进而减少疾病的发生，改善卫生保健可及性和服务质量，促进健康状况和风险分担，提高这些人群的抗疾病风险能力，从而促进公平、改善质量和提高效率。但这种模式具有一定的无奈性。因为其保险基金有限，风险池太小，而且容易出现逆向选择问题，对政府补助金存在过度依赖，筹资与管理存在一定的困难，难以实现可持续性发展。

第三节 | 我国医药卫生体制改革伦理

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平，是医药卫生体制改革的出发点和落脚点。

一、医药卫生体制改革的背景与历程

（一）医药卫生体制改革的背景

中华人民共和国成立初期，最基本的医疗卫生体系极为薄弱，社会公众的健康缺乏保障，婴儿死亡率接近200‰，孕妇死亡率高达1 500/10万，人均预期寿命也只有35岁。为了解决人民群众的基本健康问题，国家组织开展了规模庞大的卫生运动，主要任务是建立公共卫生服务体系，发展壮大城乡基层医疗卫生服务组织，向人民群众提供传染病防治、妇幼保健为主的基本医疗卫生服务。1950年第一届全国卫生会议召开，提出了“面向工农兵、预防为主、团结中西医”的卫生工作方针，1951年，卫生部颁布了《农村卫生基层组织工作具体实施办法（草案）》，确定了中华人民共和国成立初期的基本医疗卫生服务内容。政府对医疗服务、医疗保障、卫生防疫等实行统一管理，逐步形成了包括医疗、预防、保健、康复、教学科研等在内的比较完备的、布局相对合理的医疗卫生保健制度和运行体系。

其政策措施和经验可以概括为：建立城乡“三级医疗预防保健网”，基本消除了居民对卫生服务可及性的障碍；建立城乡医疗保障网，到改革开放前，公费医疗制度和劳保医疗制度以及农村合作医疗制度已经覆盖了全国绝大多数人口；来自政府和集体的公共资金，支付了绝大多数卫生总费用和其他卫生公共产品；控制了卫生服务的筹资和提供系统的费用，1978年全国卫生总费用仅占GDP的3.02%，其中患者自费部分占20.4%；动员全民广泛开展爱国卫生运动，显著改善了公共卫生环境和个人卫生习惯等。

（二）医药卫生体制改革的历程

从1978年开始，我国的医药卫生体制改革主要经历了三个大的阶段。

1. 第一阶段　改革开放后，随着经济发展、生活改善，人们对医疗卫生服务需求的迅速提高。当时改革要解决计划经济体制下的如下问题：国家包揽太多，医疗机构活力不足、效率低下，卫生服务供给远远不能满足广大人民群众的需求。扩大卫生服务供给，搞活卫生机构内部运行机制就成为主要任务。1979年国家层面提出“运用经济手段管理卫生事业”“卫生部门也要按经济规律办事”的主张。1985年国务院批转了卫生部《关于卫生工作改革若干政策问题的报告》，明确指出：必须进行改革，放宽政策，简政放权，多方集资，开阔发展卫生事业的路子，把卫生工作搞好。医疗机构向市场化转型的序幕由此拉开，因此这一年被称为“医改元年”。

2. 第二阶段　随着市场经济体制的逐渐建立，卫生事业的外部环境发生了很大变化，社会其他行业的市场化改革不断加速，带来了医疗卫生领域的危机感。1992年9月，国务院下发了《关于深化卫生改革的几点意见》，其中最主要的改革内容就是对医院补偿机制的改革。随着改革开放的推进，卫生领域中一些源于计划经济的深层次矛盾和体制、机制方面的问题进一步暴露，已经越来越不适应市场经济发展的要求。为此，中共中央、国务院于1996年底召开全国卫生工作大会，1997年初发布《关于卫生改革与发展的决定》，全面展开适应市场经济体制的卫生改革，随后发布了一系列卫生改革的文件。

3. 第三阶段　随着社会主义市场经济体制的进一步完善，出现了如下问题：医疗卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不适应；城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱，医疗保障制度不健全，药品生产流通秩序不规范，政府卫生投入不足，医药费用上涨过快，个人负担过重。对此，人民群众反映强烈。

2009年，中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》发布，其最大亮点是：强化政府责任，公立医院回归公益性；提出完善四大医药卫生体系，以建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；完善八大体制机制，以保障医药卫生体系有效规范运转。随后国务院下发《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）》，新医改启动。2016年8月全国卫生与健康大会召开，提出没有全民健康，就没有全面小康。同年，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，提出了“三步

走”计划。2022年4月国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》，提出到2035年，建立与基本实现社会主义现代化相适应的卫生健康体系，中国特色基本医疗卫生制度更加完善，人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右，人均健康预期寿命同比例提高。2022年，党的二十大报告提出，要深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；深化以公益性为导向的公立医院改革，规范民营医院发展等，为今后的医药卫生体制改革指明了方向。

二、医药卫生体制改革的主要内容

（一）全面加强公共卫生服务体系

建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

具体措施包括：确定公共卫生服务范围。明确国家基本公共卫生服务项目，逐步增加服务内容。完善公共卫生服务体系。明确公共卫生服务体系的职能、目标和任务，优化人员和设备配置，探索整合公共卫生服务资源的有效形式。加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制，加强对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。构建资源联动、统一质控、信息共享的公共卫生实验室检测网络，提升检验检测能力。加强城乡急救体系建设，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。加强健康促进与教育。深入开展爱国卫生运动。加强卫生监督服务。

（二）进一步完善医疗服务体系

坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系。优化资源配置，加强人才队伍建设，推进能力现代化。加强分工合作，促进分级诊疗，推进体系整合化。提高服务质量，改善服务体验，推进服务优质化。加强科学管理，压实责任，推进管理精细化。深化体制机制改革，提升动力，推进治理科学化。

具体措施包括：大力发展农村医疗卫生服务体系。健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。优化乡村医疗卫生机构布局，强化和拓展县域医疗卫生体系服务功能。推进县域医共体建设。在农村地区以县域为单位发展医共体，由县级医院牵头，其他若干家县级医疗卫生机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心等为成员单位。完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，在城市地区网格化布局由市级医院、区级医院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构、安宁疗护机构等组成的医疗联合体。健全各类医院的功能和职责。构建公立医院高质量发展新体系，打造国家级和省级高水平医院。发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用。

（三）加快建设医疗保障体系

国家建立以基本医疗保险为主体，商业健康保险、医疗救助、职工互助医疗和医疗慈善服务等为补充的、多层次的医疗保障体系。鼓励发展商业健康保险，满足人民群众多样化的健康保障需求。完善医疗救助制度，保障符合条件的困难群众获得基本医疗服务。基本医疗保险包括职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险。充分发挥全民基本医疗保险的基础性作用，重点由扩大范围转向提升质量。

具体措施包括：巩固扩大基本医疗保险覆盖面，提高基本医疗保障水平，完善基本医疗保险管理体制，提高基本医疗保险管理服务水平，通过支付制度改革，加大医疗保险经办机构和医疗机构控制医药费用过快增长的责任。在继续提高基本医疗保险参保率基础上，稳步提高基本医疗保障水平，着力加强管理服务能力，切实解决重特大疾病患者的医疗费用保障问题。

（四）建立健全药品供应保障体系

加快建立以国家基本药物制度为基础的药品供应保障体系，保障人民群众安全用药。完善药品供应保障制度，建立工作协调机制，保障药品的安全、有效、可及。实施基本药物制度，遴选适当数量的基本药物品种，满足疾病防治基本用药需求。

具体措施包括：公布基本药物目录，根据药品临床应用实践、药品标准变化、药品新上市情况等，对基本药物目录进行动态调整。基本药物按照规定优先纳入基本医疗保险药品目录。提高基本药物的供给能力，强化基本药物质量监管。建立健全以临床需求为导向的药品审评审批制度，支持临床急需药品、儿童用药品和防治罕见病、重大疾病等药品的研制、生产，满足疾病防治需求。

（五）完善医药卫生领域体制机制

完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管体制机制，加强科技与人才、信息、法治建设，保障医药卫生体系有效规范运转。

具体措施包括：建立协调统一的医药卫生管理体制，实施属地化和全行业管理，强化区域卫生规划，推进公立医院管理体制改革，进一步完善基本医疗保险管理体制。建立高效规范的医药卫生机构运行机制，公共卫生机构收支全部纳入预算管理，转变基层医疗卫生机构运行机制，建立规范的公立医院运行机制，健全医疗保险经办机构运行机制。建立政府主导的多元卫生投入机制，明确政府、社会与个人的卫生投入责任。建立科学合理的医药价格形成机制。建立严格有效的医药卫生监管体制。建立可持续发展的医药卫生科技创新机制和人才保障机制。建立实用共享的医药卫生信息系统。建立健全医药卫生法律制度。

（六）建立强有力的实施保障机制

把解决群众看病就医问题作为改善民生、扩大内需的重点摆上重要议事日程，明确任务分工，落实政府的公共医疗卫生责任。形成政府主要领导负总责，分管常务工作和卫生工作的领导具体抓，各有关部门分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

国家负责制定试点原则和政策框架，统筹协调、指导各地试点工作。各省区市制定具体试点方案并组织实施。鼓励地方在中央确定的医改原则下，结合当地实际，开展多种形式的试点，积极探索有效的实现途径，并及时总结经验，逐步推进。

坚持正确的舆论导向，做好医改政策的宣传解读，及时解答和回应社会各界关注的热点问题，大力宣传医改典型经验和进展成效，合理引导社会预期，在全社会形成尊医重卫、关爱患者的风气，营造改革的良好氛围。

三、医药卫生体制改革中的政府责任

保障公民的健康权是一种重要的国家责任，《关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出如下原则：坚持公平与效率统一，政府主导与发挥市场机制作用相结合。可以说，政府主导是政府在医药卫生体制改革中的责任，具体来说包括以下四个方面的责任。

（一）领导责任

1. 引领医改价值目标　健康是人类社会经济发展的需要。对于一个国家来说，保护和促进国民健康，既是保护和开发劳动生产力的需要，也是维持生产力要素再生产的需要，同时也是国防安全的基础。追求健康和长寿，是人的本能之一。在现代社会，影响人类健康的因素主要有五类，即收入水平、生活方式、遗传、环境污染和职业风险、可获得的医疗服务及其质量，后四类因素都与医疗卫生服务和干预有密切关系。世界各国的医改，都是其政治、经济制度变革和社会发展进程的组成部分。因此，各国医改目标的确定，同本国的政治、经济、社会变革与发展现状及长远目标相联系。

纵观世界各国的医改，可以看到具有共性的、核心的目标是：在预算允许的范围内，最大限度地改善公民的健康状况，包括提高平均预期寿命，降低疾病负担，提高生产效率，改善生活质量。健康是基本人权，是人全面发展的基础，医药卫生事业关系千家万户幸福，是重大民生问题，因此医疗卫生更应

强调公平，而要实现医疗卫生公平，仅仅依靠市场机制的基础性作用显然是不可能的。因此，需要发挥政府在实现医疗卫生服务公平价值中的主导作用。

政府首先需要确立医疗卫生的公平价值理念，并将这种价值理念贯彻到政府的医改政策之中。医疗卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业，我国深化医改要坚持“人民至上”和“生命至上”，把维护人民健康权益放在第一位。坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则。

2. 制定卫生发展战略　卫生发展战略（health development strategy）是根据卫生事业发展和改善人民健康的需要，对关乎卫生事业全局的、长远的、重大的问题进行全局性、规律性、层次性和决定性的谋划。卫生发展战略是国家经济社会发展战略的重要领域，并与国家经济社会发展战略保持协调。它从大健康、大卫生、大医学的角度出发，将健康战略融入社会经济发展之中，从而创造有利于人民健康的社会、经济和生活环境，并通过人民健康水平的提高来推动经济发展和社会进步。

中华人民共和国成立以来，在不同时期制定的卫生工作方针均能立足于中国的国情，促进了中国卫生发展战略的形成，推进了中国卫生发展战略目标的实施。从20世纪70年代末开始，中国和联合国的世界卫生组织及开发计划署合作，在中国建立了5个初级卫生保健合作中心和6个农村卫生示范县。20世纪80年代，中国政府明确对“2000年人人享有卫生保健”全球战略目标作出承诺。1997年，中共中央、国务院颁布《关于卫生改革与发展的决定》，确定了中国卫生事业发展的战略重点是农村卫生、预防保健、中西医并重。2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平。这为新时代中国的医改进一步明确了方向和重点。

（二）管理责任

1. 构建卫生管理体制　卫生管理体制（health management system）是指一个国家或地区各级政府及相关卫生组织体系构架、机构设置、隶属关系、权限职责划分及其相互关系运作制度化的总称。它是国家管理卫生事务的主体，将直接关系到医改目标是否实现，关系到公众及社会健康保障。

卫生管理体制构建的目标是：按照精简、统一、协调、高效的原则，以卫生行政决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调为要求，构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的卫生组织结构；建立符合社会经济规律和公众健康需求的卫生服务体系；建立权责明晰、富有生机和活力的医疗机构管理体制，使医疗机构真正成为自主管理、自我发展、自我约束的法人实体；完善卫生监督管理体制，明确卫生监督的主体、内容及方式，使卫生行政、管理和服务在阳光下运行。

《关于深化医药卫生体制改革的意见》对建立协调统一的医药卫生管理体制提出了明确规定，就是要实施属地化和全行业管理。所有医疗卫生机构，不论所有制、投资主体、隶属关系和经营性质，均由所在地卫生行政部门实行统一规划、统一准入、统一监管。

2. 理顺卫生管理机制　卫生管理机制（health management mechanism）是指卫生事业有机体的内部相关要素或活动之间相互影响、相互作用、相互协调的运行方式、手段和具体制度的总和。可以说，只有探索建立和遵循卫生管理机制，卫生事业这个有机体才可能得以有效运转和持续发展。

卫生事业有机体的整体运行也包含着它的相关构成要素的局部运行。各构成要素都自成体系，各自也有其特定的运行机制。卫生管理机制按其内容可分为卫生机构、卫生人员、卫生经费、卫生物资与设备、卫生技术、卫生监督等管理机制；按其作用方式可分为政府主导的卫生行政管理机制、卫生服务市场管理机制等；按照医院举办方的不同又可分为公立医院管理机制和私立医院管理机制。

医改就是要建立高效规范的医药卫生机构运行机制。公共卫生机构收支全部纳入预算管理。按

照承担的职责任务，由政府合理确定人员编制、工资水平和经费标准，明确各类人员岗位职责，严格人员准入，加强绩效考核，建立能进能出的用人制度，提高工作效率和服务质量。转变基层医疗卫生机构运行机制。建立和完善医院法人治理结构，明确所有者和管理者的责权，形成决策、执行、监督相互制衡，有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的公立医院运行机制。

3. 管理医疗服务市场　我国的医改坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合，引入市场竞争机制是医改的一个重要思路。但医疗卫生服务作为一种特殊服务，具有明显的垄断性、信息不对称性等特点，医疗卫生服务机构很容易利用其优势，产生垄断行为，损害患者利益，这就要求政府应规范医疗服务行为，通过制定法规、政策使医疗服务行为得到有效规范，保障医患双方的合法利益。又由于医疗卫生服务行为需求的特点并非人们所能完全控制和计划的，导致医疗卫生服务供给的不确定性，政府又不能完全放任不管，让市场对医疗卫生资源进行自行调节，所以必须加强政府宏观调控。

当前，政府对医疗服务竞争的管理中，存在着下面一些问题，需要通过深化医改予以消除。一是尚缺乏政府管理市场竞争的成熟制度安排，医疗保障体系和保障水平还有待完善提高；缺乏完整的初级医疗服务体系以及守门人制度；尤其是提供医疗服务的公平竞争局面尚未形成，公立医院的竞争格局难以打破等。二是市场竞争管理制度安排给医疗保障体系设立了过高比例的自付额度以致部分丧失了保障功能；大多数医疗服务提供机构因公私不分而治理结构不清。三是对于一些市场可以发挥较大作用的领域，如医疗服务的提供和药品价格的确定等，政府施加了过多不必要的管制，对自身有较强生存能力的医疗机构仍给予了大量的投入，医疗服务方面的市场垄断在一些地区也比较严重等。这些问题需要引起重视，也是深化医改的重要任务。

（三）保障责任

1. 资金保障　主要涉及卫生筹资问题。卫生筹资（health financing）是卫生资金筹集的简称。通常使用卫生总费用、人均卫生费用以及卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比重这三个指标评价一个国家或一个地区的卫生筹资水平。

卫生总费用是一个国家或地区在一定时期内（通常为一年）为了接受卫生服务而支付的卫生资金。卫生总费用的筹资渠道主要分为三类，即政府卫生支出、社会卫生支出和个人现金卫生支出。政府卫生支出是指各级政府用于医疗卫生服务、医疗保障补助、卫生和医疗保险行政管理事务等各项事业的经费；社会卫生支出是指政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投入，包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠捐助、行政事业性收费收入等；个人现金卫生支出是指城乡居民在接受各类医疗卫生服务时的现金支付，包括享受多种医疗保险制度的居民就医时自付的费用。世界卫生组织要求卫生总费用占国内生产总值的比重不低于5%，以监测和评价全民覆盖政策目标的实现程度；政府卫生支出比重一般为40%～60%，个人现金卫生支出占卫生总费用的比重不应超过30%～40%。

在我国的医药卫生体制改革进程中，政府卫生支出和社会卫生支出两类筹资渠道构成了中国卫生筹资体系的主体，近年来，居民个人现金卫生支出占卫生总费用的比重逐年降低，卫生筹资公平性逐渐趋好，卫生筹资体系整体逐渐趋向合理化。但与国际水平相比较，我国仍然需要进一步完善卫生筹资结构，提高政府卫生支出占卫生总费用的比重，降低个人现金卫生支出占卫生总费用的比重，加强卫生筹资的公平性和风险保护能力。

2. 人员保障　医药卫生体制改革目标最终要靠人去落实和实现，这就涉及卫生人力资源问题。所谓卫生人力资源（health human resource），也称卫生人力（health workforce），是指在各类卫生机构中从事和提供卫生服务相关的一切人员，主要指各类卫生技术人员，也包括卫生行政管理人员及后勤支持人员。政府需要从一个国家或地区的角度，通过协调卫生人力规划、培训和使用三个关键环节，采用政策、法规、经济等手段，促进卫生人力和卫生服务的协调发展，使卫生人力在数量、质量、结构和分布四方面适应居民对卫生服务的需求。

（四）监督责任

1. 监督范围　对卫生事业的监督既是政府的法定责任，也事关医改的目标实现。从监督的内容来看，一般包括卫生资金监管、医疗服务质量监管、卫生监督、药品监督检验等。

卫生资金监管（health fund supervision）是指政府及相关部门对卫生系统资金的运行进行事前、事中、事后全过程的监督、管理活动。医疗服务质量监管（quality supervision and management of medical service）是为了保证服务质量而对各项医疗服务的准入、生产、提供等全过程进行的监督与管理。公共卫生监督管理是国家卫生行政机构或行政性组织，依据法律法规对社会公共卫生事务进行监督管理的一种行政行为，是国家行政权力的重要组成部分。药品监督检验是根据法律规定，对研制、生产、经营、使用的药品质量进行的检验，根据目的和处理方法不同，药品监督检验可以分为抽查性检验、评价性检验、仲裁性检验和国家检定四种类型。

2. 卫生系统绩效评价　医改是有目的的行为，目标是否实现以及实现程度如何需要作出评价并反馈至医改决策者，这就涉及卫生系统绩效的评价问题。

卫生系统绩效的实质是卫生系统总体目标的实现程度。卫生系统绩效评价是通过建立一套指标体系，采用统计学方法对一个国家或地区基于其卫生系统目标的实现程度进行监督、评估、反馈和预测的过程，从而保证系统的有效性、公平性、效率和质量。卫生系统绩效评价的目的就是通过提供有关政策及卫生系统发展的可靠信息来增强决策者的能力；通过提供健康改善情况信息来提高公众的能力。WHO 一直致力于发展系统化的、具有横向和纵向可比性的方法来监控各国的卫生系统绩效。2000 年，WHO 决定将“加强和改进卫生系统绩效”作为《世界卫生报告》的主题，并将其作为四个战略方向之一，从而引起世界各会员国的注意，并将改进绩效纳入各国医改的核心任务。

思考题

1. 简述医院管理存在的伦理问题。
2. 简述医院管理中的伦理要求。
3. 简述卫生保健制度的核心价值。
4. 简述政府在我国医药卫生体制改革中的责任。

（陈士福）



本章数字资源

第十六章 医学伦理决策

卫生健康管理、诊疗、护理等行为既是管理、专业技术行为，又是医学伦理行为。卫生健康管理人员在开展管理决策时，医务人员在进行诊疗护理决策时，医学伦理和医学道德是不可缺少的考虑因素。因此，卫生健康管理人员的行政管理决策和医务人员的诊疗护理技术决策又是医学伦理决策。管理人员和医务人员应该为自己的医学伦理决策创造条件，从容进行医学伦理决策。面对一般的医学伦理问题，管理人员和医务人员应该认清影响因素，择善祛恶，完善德行，正确进行普通医学伦理决策。在遭遇医学伦理两难问题时，管理人员和医务人员更应学会识别伦理难题，剖析难题产生的原因，破解伦理难题，顺利进行伦理难题决策。

第一节 医学伦理决策概述

医学伦理决策是对医学伦理问题的识别和评估，并在此基础上形成和实施最优化目标和行为方案的过程，医学伦理决策就是医学伦理行为决策，医学伦理行为包含“动机与效果”“目的与手段”以及“过程与结果”三种不同结构，医学伦理决策是一个过程且可以模式化，医师应该积极为伦理决策创造条件。

一、医学伦理决策的概念

（一）医学伦理决策的含义

决策是指人们在改造世界过程中，寻求并决定某种最优化目标和行为方案。医学伦理决策（decision-making of medical ethics）是指决策主体识别医学伦理问题、评估医学伦理行为方案、形成伦理行为意图和实施伦理行为方案的过程。医学伦理决策主体既包括医务人员个人，又包括卫生健康行政主管部门、医疗卫生单位等非自然人。狭义的医学伦理决策主体专指医师。医学伦理决策的四个阶段为：①伦理认知，即决策主体意识到医学伦理问题的存在；②伦理判断，即决策主体对可选择的行为方案做道德评价；③伦理意图，即决策主体主观上选择什么样的行为；④伦理行为，即决策主体实施伦理意图，表现出外在的道德或不道德行为。本章主要从狭义角度阐释医学伦理决策。

医学伦理决策实际上是医学伦理行为的决策，因此首先需要理清“医学伦理行为”这个基本概念。

从伦理道德的角度，人们的行为可以分为伦理行为和非伦理行为：前者是指在一定的道德意识支配下发生的，有利于或有害于社会和他人的行为；后者是指不受一定道德意识支配或不具有利害效用的行为，即无道德意义、不能进行道德评价、无所谓道德不道德的行为，如严重精神病患者的行为。伦理行为又可以进一步分为道德行为和不道德行为：前者是指具有有利效用的行为；后者是指具有有害效用的行为，也称“败德行为”。

所谓医学伦理行为是指医师在一定的道德意识支配下发生的有利于患者、社会和科学的行为。这里的道德意识是指支配医师诊疗行为的具有利害效用的思想。伦理行为是客观的，而道德意识是主观的。可见，一方面，医学伦理行为包括主观因素和客观因素：主观因素是驱使医师进行某种伦理行为的思想意识，即所谓的伦理行为动机；客观因素是医师实际进行的某种伦理行为，即所谓的伦理

行为效果。另一方面，医学伦理行为包括伦理行为目的和伦理行为手段：目的是医师自觉、主动设定和追求的伦理行为结果；手段则是医师为达到伦理行为结果而在伦理行为过程中所采取的方式和方法。因此，“伦理行为动机与效果”“伦理行为目的与手段”以及“伦理行为过程与结果”是医学伦理行为的三种不同的结构。

首先，“伦理行为过程与结果”是医学伦理行为客体性的行为结构，是医学伦理行为的自然结构，也是最简单的结构。其次，“伦理行为目的与手段”是基于医学伦理行为主体性的行为结构，是医学伦理行为的主体性结构，是基于医师“伦理行为过程与结果”的更为复杂的结构：目的是达到伦理行为结果，手段则是在伦理行为过程中所采取的方式和方法。最后，“伦理行为动机与效果”则是医学伦理行为的主客观结构，是基于医师“伦理行为目的与手段”的最为复杂的结构：伦理行为动机是对伦理行为目的和手段的思想和意识；伦理行为效果则是伦理行为动机所引发的实际呈现的伦理行为目的与手段。

这样看来，一方面，“伦理行为效果”与“伦理行为结果”不同：伦理行为效果是伦理行为动机的实际结果，不仅包括实际存在的伦理行为结果，还包括实际发生的整个行为过程。另一方面，“伦理行为动机”与“伦理行为目的”不同：伦理行为动机是对伦理行为目的和手段的思想和意识，因而不仅包括预想的伦理行为目的，还包括预想的在伦理行为过程中将采取的方式和方法。

（二）临床诊疗决策与医学伦理决策之间的关系

医学伦理行为是医师在具有利害效用的意识支配下而采取的行为，临床诊疗行为也必然是对患者具有利害效用的行为，因此，医师的诊治行为自然蕴含着丰富的伦理因素和成分，诊疗行为同时也是伦理行为，但医师也可能进行独立的伦理行为，例如保守医疗秘密、尊重隐私、人文关怀等并非具体的诊疗行为。

临床诊疗决策（clinical decision-making）是指医师根据临床医学的专业理论、方法和经验，经过反复研究和运用科学思维而提出疾病诊治的方案。医师在决策的过程中，要根据确定的诊疗目标，拟订不同诊疗方案，然后从中选出达到诊疗效果的最佳方案。医师临床诊疗决策会涉及诸多因素，其中诊疗技术和医学伦理是不可分割的两个方面。医师做临床技术决策，即回答解决是与非、有没有能力做、可行不可行等问题的同时，还必然进行伦理决策，即回答解决善与恶、应当不应当做、值得不值得做等问题。也就是说，医师进行临床诊疗决策，要建立在其道德思考的基础之上，识别其中的医学伦理问题，从道德上评估不同诊疗方案，还会涉及患者及其家属的价值观，同时受到不同社会文化、风俗习惯、法律规范、宗教信仰等的影响。

（三）医学伦理决策的类型

按照不同的标准，可以对医学伦理决策进行不同分类。其中从决策主体的角度可分为个人决策和团体决策。医师在医学伦理决策的过程中，应特别注意个人决策和团体决策。个人决策是指由医师自己作出医学伦理决策。在通常情况或紧急情况下，大多需要医师通过个人决策来决定诊疗方案，当然，医师也应该能够为自己形成的诊疗行为决策进行伦理辩护。团体决策是指医疗机构组成一个团体，例如医学伦理委员会，经过团体讨论之后才作出决定。对于非常复杂的诊疗情况，或涉及群体利益的时候，需要多背景的专家以及利益相关者代表集思广益，通过大家的智慧进行决策。

二、医学伦理决策的具体过程

（一）识别有关伦理问题

医学伦理决策源于医师对诊疗中伦理问题的认知，医师应该根据诊疗问题的特征来判断伦理问题的存在与否。临床诊疗过程中的伦理问题是有关“应该做什么”和“应该如何做”，即医师是否“应该”如此诊疗？根本来说，医师的诊疗行为是否能够获得好的效果？是否符合某些道义？是否会影响到医师的品德？具体来说，医师的诊疗行为是否符合已有的医学伦理原则和规则？例如，医师如何

诊疗最有利于患者？如何尊重患者的自主？如何贯彻知情同意？家属要求对癌症患者的患病信息保密，医师应该如何对待？医师应该如何让患者及其家属参与到临床决策之中？某种诊疗行为是否是一个好医师应该做的？诸如此类。

（二）确定医学伦理行为目标

医学伦理行为是医师有意识地“为了什么”而进行的临床诊疗活动，因此，医师进行医学伦理行为决策，首要的就是确定医学伦理行为目标。任何决策都是为了达到一定的目标，或者说是为了解决某一问题。确定目标是进行决策的第一步，而决策所要解决的问题必须十分具体，所要达到的目标必须十分明确。如果问题不具体，目标不明确，决策将是盲目的。医师在确定合乎伦理的诊疗行为目标时，需要注意如下两个方面。

1. 确定目标要基于患者的病情、医院及医师的实际情况　这是诊疗决策合乎伦理的前提。不以患者的病情为基础的诊疗决策和脱离医院设备设施实际条件及医师技术能力的诊疗行为决策，不可能是准确的诊断和有效的治疗，必然是不符合伦理的。

2. 确定的诊疗行为目标应该是适宜的　如果医师确定的诊疗目标过低，实际上是一种医疗失职；如果确定的诊疗目标过高，则是不切合实际的，要么让患者承担不必要的诊疗风险，要么引发过度医疗，增加患者的经济负担，都是不合乎伦理的。

（三）拟定医学伦理行为备选方案

医师进行医学伦理行为决策需要有两个及以上备选方案，拟定不同的诊疗手段。如果仅有一个备选方案，就不存在决策问题。因而，医学伦理决策要有两个或两个以上诊疗行为方案，医师才能从中进行比较和选择，最后选中那个令人满意的诊疗行为方案。

尤其需要注意的是，医师在拟定诊疗行为备选方案时，应该列出所有可能的诊疗方案。有的医师往往只列出最简单的两个：“做”或者“不做”，不愿意考虑更多的可能。实际上，解决问题的方法往往不止两个，即使有时乍看起来认为不可行的诊疗方案也应全部列出。因为有时初看起来不行的办法，经过进一步考虑会发现是可取的或不得不采取的。

（四）确定医学伦理行为方案

医学伦理决策过程实质上是选择诊疗行为方案的过程。因此，医学伦理行为决策的关键环节是确定诊疗行为方案。确定诊疗行为方案尤其需要注意以下两个方面。

1. 确定诊疗行为方案需要经过患者的知情同意，尊重其自主性　医师在确定诊疗目标，拟定诊疗方案时已经充分考虑了患者的风险、获益，以及患者的意愿、偏好等伦理因素。但在确定最终诊疗方案时，更需要尊重其自主性。具体思路是医师要加强与患者的沟通，告知患者医师提出的最佳方案，即选中的令人满意的诊疗行为方案，取得患者的知情同意。

近年来，医患共享决策理念引起人们的重视。共享决策（shared decision-making）强调医患双方信息共享、患者充分参与到临床决策中。一方面，医师要在评估患者参与决策意愿和能力基础上，恰如其分地鼓励、支持患者平等参与到诊疗方案的讨论和选择之中；另一方面，要求来自医患双方的信息要顺畅流动、充分共享，医师要充分告知备选诊疗方案、各自利弊，而患者要及时向医师表达看法和疑虑，包括价值观、选择偏好等。

2. 应该选择使患者受益与代价比例适宜的诊疗方案　经过伦理决策的临床诊疗方案应该是最优的。所谓的“受益”，是指需要综合考虑患者所患疾病的性质、患者的意愿和偏好、医院和医师的设施设备技术条件、患者的支付能力等因素，作出对患者有益的选择；所谓的“受益与代价比例适宜”，是指需要进一步综合考虑痛苦、损伤、副作用、费用支出等因素，选择最优方案。

（五）实施医学伦理行为方案

选定诊疗方案必须付诸实施，采取医学伦理行为，即通过一定的临床诊疗手段，将诊疗行为动机和意图实现为诊疗行为效果，达到一定的诊疗结果。如果选择后的诊疗方案不付诸实施，就等于没有决策。因此，诊疗伦理决策不仅是一个认识过程，更是一个行动过程。

NOTES

三、医学伦理决策的模式化

将医学伦理决策纳入一个既定的框架，即确立医学伦理决策模式（decision-making model of medical ethics），可以使医师按照一定固定程序进行医学伦理决策，无疑有利于提高决策的效率。20 世纪后期以来，诸多学者提出了不同的伦理决策模式，如柯廷（Curtin）、阿洛斯卡（Aroskar）、海因斯（Hynes）、汤普森（Thompson）、德沃尔夫（DeWolf）等伦理决策模式。

借鉴上述不同决策模式，结合我国实际，医师可以按照如下模式（图 16-1）进行伦理决策。

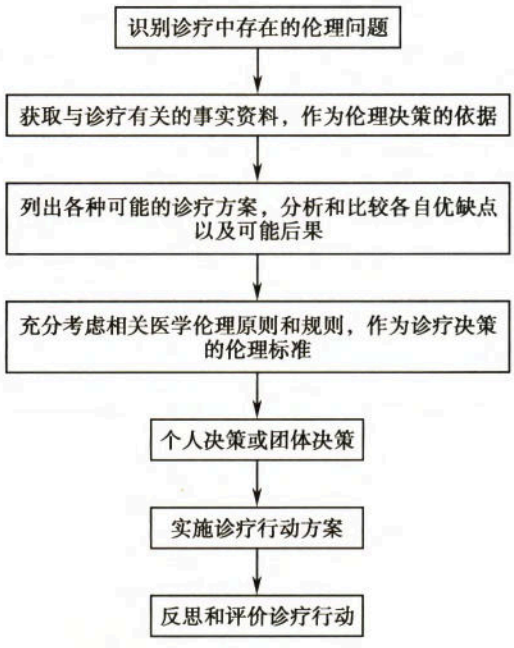


图 16-1　我国医学伦理决策参考模式

四、医学伦理决策的条件准备

（一）熟悉有关医学和医学伦理知识与技能

一方面，正确进行临床诊疗决策需要丰富的医学知识和良好的专业技能。医师的临床诊疗行为是建立良好医患关系的专业基础，正是诊疗行为将医院及医师与患者及其家属联系在一起，医师的伦理决策与技术决策是不能截然分开的。因此，医师只有掌握丰富的医学知识，掌握高超的专业技能，才能及时、准确、有效、最优地进行诊断和治疗，才能从多个诊疗方案中确定出最佳的方案，进行包括伦理因素在内的诊疗决策。

另一方面，掌握有关医学伦理知识，具有一定医学伦理意识，具备基本伦理决策能力，更是进行医学伦理决策的前提和基础。医师应该通过医学伦理教育和继续教育，学习并掌握有关医学伦理知识和基本技能。通过学习与训练，把握医学伦理学的理论和原则，尤其国际国内公认的医学伦理原则和有关医学伦理规范文件提出的基本道德要求；掌握关注医学伦理问题的诸多方法。在此基础上，形成自己的职业伦理价值观，提升自己的医学职业精神。同时应该把握医学伦理决策的方法和技巧，提高自己的医学伦理决策能力。

（二）了解患者及其家属的价值观

随着患者权利意识的不断增强，医师在进行医学伦理决策时，应该注意了解患者及其家属的价值观，以及对于自己疾病的诊治是否已经作出了某些决定。在强调尊重患者自主性和知情同意权的今天，做到这一点是非常重要的。医师应善于与患者及其家属进行沟通和交流，了解他们的想法，尤其是某些价值偏好，并帮助他们尽量摆脱某些不合时宜的价值观所造成的不利影响。只有如此，最终的临床诊疗决策才是合乎伦理的。

（三）掌握有关法律规定、规章制度与技术规范

目前，这些规定包括：《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》对健康权的规定，《中华人民共和国民法典》关于人格权和医疗侵权方面的规定，《中华人民共和国医师法》对于医师执业规则的规定，《中华人民共和国传染病防治法》对于传染病防治规则的规定，还有大量的医疗卫生法律法规的有关规定，另外还有健康中国、深化医药卫生改革等医疗卫生政策的有关规定。

现代化医疗机构工作信息量大，随机性强，工作繁杂，分工精细，协作紧密，这就需要建立一整套严格的规章制度，例如卫生部颁布的《全国医院工作条例》《全国医院工作制度与人员工作职责》《病历书写基本规范》和国家卫生健康委员会颁布的《医疗技术临床应用管理办法》等部门规章、制度规定乃至技术常规、医德医风和行政管理规定等。这些规章制度与技术规范也是医师诊疗行为的标准。

NOTES

因此，医师应当熟悉掌握有关法律法规和政策以及规章制度与技术规范，在此基础上正确进行医学伦理决策。

（四）参考伦理委员会的建议

医学伦理委员会是建立在医院等基层卫生单位中，由多学科人员组成，为发生在医疗实践和医学科研中的医德问题和伦理难题提供教育、咨询等职能的机构。医学伦理委员会具有教育培训、建议咨询、审查评价等多种功能，医师可以将比较棘手的医学伦理问题个案，提交到医学伦理委员会，使个人决策变为团体决策。伦理委员会的成员专业背景不同，经过集体讨论，发挥团体尤其是医学伦理专业人员的智慧，就能够使伦理决策更为可靠和科学。

医师还可以积极创造条件，争取作为委员参与医学伦理委员会，这无疑会大大提高医师医学伦理决策的能力和水平。

第二节 | 普通医学伦理问题的决策

善恶决策是最为普通、最为常见的医学伦理决策，医务人员应该择善祛恶、力避“败德行为”。影响普通医学伦理问题决策的因素很多，需要厘清这些因素，从而有针对性地寻求正确进行普通医学伦理决策的策略。

一、普通医学伦理问题决策的概念

普通医学伦理问题决策（decision-making of general medical ethics issue）是指医师面对善与恶的行为选择而进行的医学伦理决策。不言而喻，此时医师应该遵循社会医德要求，择善祛恶，完善德行，养成美德。然而，个别医师经不住某些不当利益的诱惑，可能为了一己私利，而置患者利益和社会公益于不顾，选择不符合甚至违背医学道德的行为。

从医学道德终极标准来看，不道德的诊疗行为是指有损他人利益尤其是患者利益的行为。主要包括以下几种情形：第一，在医患双方利益发生冲突不能两全时，不惜牺牲患者的利益而损人利己；第二，在处理不同患者之间利益关系时，不能公平合理地予以对待，实现最大多数患者的最大利益；第三，在人们利益并不冲突而可以两全时，并没有做到无害一人地增加利益总量。

从医学道德规范体系来看，不道德行为主要包括有违医德基本原则、医学伦理原则和具体医学道德基本规范等的诊疗行为。

二、普通医学伦理决策的影响因素

（一）个体因素

个体因素是指医师个人的伦理价值观、道德信仰以及人格特征，即医师个人的医德素养。医师个人的医德素养如何，往往决定着该医师作出的临床诊疗决策是否符合伦理，其诊疗行为是道德的还是不道德的。持这种观点的理论被称为“烂苹果”理论。持这种观点的人认为，不道德的诊疗决策大多是由医德素质较低的医师个人作出的。这些医师的医德认知水平较低，或道德人格存在一定缺陷，例如，有着强烈的金钱、权力、利益欲望，这些人格特征容易使他们作出不道德的诊疗决策。相反，道德的诊疗决策往往是由道德素质较高的医师个人作出的，他们的医德水平较高，对自身的诊疗行为具有很好的道德调控能力，并且能够抑制不良欲望，能够保证自己的诊疗行为合乎伦理。

（二）社会组织环境因素

这里的社会组织环境因素主要是指卫生健康行业和医疗卫生机构的道德氛围。医师的医德素养能够稳定地影响个人的态度和行为，但它是在一定的社会组织环境中形成的，并且受到社会组织环境因素的影响，处于不断变化的过程之中。持这种观点的理论被称为“烂筐”或“染缸”理论。持这种观点的人认为，医师不道德的诊疗行为决策主要是由社会组织环境因素决定的，不能单纯从医师个体

身上找原因。卫生健康行业和医疗卫生机构等社会组织环境应该对其成员的不道德行为负责，不是“烂苹果”带坏了组织，而是组织如同一个“大烂筐”或“大染缸”，使其成员习得了某些不道德的行为。医师能够作出不道德行为决策，是因为医疗行业和医疗机构等社会组织提供了实施不道德行为的机会和资源，或者某种不道德的诊疗决策得到了同事、管理层乃至整个行业从业人员的默许。

（三）个体和组织环境因素的互动

单纯从医师个体本身或者单纯从个体所处的社会组织环境来解释医师的医学伦理行为是不完整的，应将两个方面结合起来对医师的医学伦理行为进行阐释。医师不道德的临床诊疗决策，会受到个体和情境两个方面因素的相互作用。持这种观点的理论被称为“互动”理论。持这种观点的人认为，一个医德素养不太高的医师，如果处在抵制不道德行为的社会组织环境中，就会作出较少的不道德决策；相反，一个非常有正义感的医师，在默许甚至鼓励不道德行为的组织和环境中，也会受到某些负面影响。医德素养不同的医师受到社会组织环境因素影响的程度是不同的，医德素养较高的医师能够较少地受到外界环境的影响和制约，医德素养较低的医师个体则会更大程度地受到组织环境因素的影响。同时，医师个体又会影响组织与环境，如果组织中有许多医德素养较高的医师个体，组织的整体氛围便会逐渐改变，这些个体医师会引导组织建立一种积极向上的氛围，但是如果大多数成员医德素养低下，一般而言，他们也会将组织向坏的方向引导。

（四）医学伦理问题本身因素

医学伦理决策源于医师对医学伦理问题的识别和认知，医师根据医学伦理问题本身的特征来判断伦理问题的存在与否，而且医学伦理问题的特征会影响其进行医学伦理判断，形成决策意图和实施决策行为。这些特征被称为道德强度（moral intensity），即道德上的压力或紧迫性。这些道德强度包括诊疗行为导致的各种结果总量、结果发生的可能性、各种结果发生的时间间隔、是否符合有关医学道德规范等等。持这种观点的理论被称为问题权变理论。持这种观点的人认为，不能离开具体的医学伦理问题本身来探究医师个体的医学伦理决策。医师进行医学伦理决策应该关注医学伦理问题本身。

三、正确进行普通医学伦理决策

（一）培育医师个体的优良道德人格

既然医师个人的医德素养是影响其普通医学伦理决策的重要因素，就应该尽可能消除不道德决策的个体因素源头。因此，一方面，医院应该通过医学伦理教育和继续教育，加强对医师的医德培育，培养更多具有更高医德修养的医务人员。另一方面，广大医师应该善于学习有关医学伦理知识，加强自我医德修养，形成正确的医学伦理价值观，提升自己的医学职业道德素养。

（二）营造良好的医学道德生态

这里的“医学道德生态”是指每个医师所处的卫生健康组织尤其是医疗机构的道德大环境。医师的道德标准都是从这些卫生健康组织中习得的，例如，在医学院校接受的医学伦理教育，工作后有关卫生健康机构、行业组织乃至医院开展的医德医风教育和建设等。医师的行为也受到医院及其成员的影响和制约，并受到社会的监督。医师个人作出某些不道德行为，是由于医院存在实施这些行为的机会和资源，或者某些不道德行为得到了管理者、同事甚至整个行业从业人员的默许。既然医疗卫生组织和社会因素是医师进行普通医学伦理问题决策的重要因素，就应该建立健全医师的医德规范、培育鼓励道德行为的伦理氛围，尤其是医疗机构管理者应该为医师树立道德楷模和行为榜样。

（三）构建个体与组织互动的平台和机制

既然医师个体与卫生健康组织之间在医学伦理方面的互动也是影响医师进行普通医学伦理决策的重要因素，就应该努力构建医师个人优良医德与良好的医学道德生态之间的平台和机制，并通过这些平台和机制促使医师正确进行普通医学伦理决策。这些平台和机制包括卫生健康行业和组织的道德自律机制、医疗机构的医德医风测评机制、医学伦理委员会的伦理审查机制等。

（四）关注具体的医学伦理问题

既然医师对医学伦理问题本身的识别和认知是影响其进行普通医学伦理决策的重要因素，伦理决策不能离开医学伦理问题本身，这就决定着伦理决策应该关注具体医学伦理问题的特征。医师应从道德直觉上，考虑对该医学伦理问题的决策是否符合有关医学伦理规范，其后果会影响到哪些人，这些人跟自己关系的远近，采取的诊疗行为会对这些人产生什么样的后果等。当然，这里的道德直觉并不是一种处于感性状态的直觉，而是一种具有理性特征的直觉。这种直觉是医师对于医学伦理问题的较为稳定的价值判断方式和经验，可以直接地断定“对与错”。

第三节 | 医学伦理难题的决策

不同于善恶决策的普通医学伦理问题决策，医学伦理难题决策是在两种甚至两种以上善的方案中进行选择，而这些善的方案又存在不同程度的矛盾和冲突，从而使医师陷入进退两难境地。伦理难题的产生存在根本原因以及某些具体原因。医师剖析这些原因有利于顺利进行医学伦理难题的决策。

一、医学伦理难题决策的概念

（一）医学伦理难题决策的含义

医师根据不同的医学伦理价值观，可以合乎逻辑地提出两种甚至两种以上不同程度矛盾和冲突的伦理行为方案，医师面对这种两难伦理行为问题的决策，称为医学伦理难题决策（dilemma decision-making of medical ethics）。医学伦理难题决策，又被称为医学道德难题决策或医德难题决策。

医学伦理难题的决策不同于普通医学伦理问题的决策，普通的医学伦理问题决策是医师在“善与恶”的行为方案中进行伦理决策，医师当然应该择善祛恶，而医学伦理难题决策，则是医师在合乎伦理而又相互矛盾和冲突的方案中进行选择，即在“善与善”的行为方案中进行选择，而这些方案又不同程度地相互矛盾和冲突，这就大大增加了决策的难度。要正确理解“医学伦理难题决策”这个概念，需要注意以下两点：

1. 医学伦理难题决策不仅仅是“两难”选择，有时可能是“多难”选择　一般认为，医学伦理难题决策是两难选择（dilemma）。但在诊疗实践中，它可能不仅仅是两难选择，有时可能是多难选择。因为医学伦理难题决策之困难并不是指在“善与恶”的诊疗行为方案中进行选择，而是指在人们认为的“善与善”的诊疗行为方案中选择。当然，这些善的行为方案不一定仅仅只有两种，而且分别不同程度地相互矛盾和冲突。

2. 医学伦理难题决策不同于一般难题决策，也不同于一般伦理难题决策　一方面，伦理难题决策不同于一般难题决策。这是因为伦理行为是具有利害效用的行为，人们对于伦理行为的选择，就比一般无关利害效用的行为选择显得更加困难。另一方面，医学伦理难题决策不同于一般伦理难题决策。这是因为医学伦理难题决策涉及的是对患者的救治行为，医师是为受到伤病折磨的人的生命和健康提供服务，与一般的伦理难题决策相比，医学伦理难题决策就需更加重视和谨慎。

3. 医学伦理难题决策尽管是具体的，但也具有抽象性　医学伦理难题一般是医师在具体的诊疗行为过程中遭遇的决策难题，具体的医学伦理难题需要具体的医师个人的努力。在此基础上，还应概括、总结普遍的医学伦理难题情况，这种脱离了具体的医师和具体的行为情境，从而具有一般意义和普遍意义的伦理难题被称为抽象的医学伦理难题，抽象的医学伦理难题需要医师探讨破解的伦理原则、规范、方法和途径等。

（二）医学伦理难题决策的有关情形

1. 当代高新医学技术开发及其临床运用引发的伦理难题决策　这些伦理决策难题主要集中在人类辅助生殖技术、死亡诊断标准和安乐死、基因诊断、基因治疗、基因编辑、基因增强、克隆技术、器

官移植、优生与生育控制、医学大数据运用、医用人工智能等诸多高新医学技术领域。生命医学科技的迅猛发展引发大量前所未有的医学伦理难题，并对人类传统的伦理观念提出挑战。面对这些问题，人们需要重新思考“我们应该不应该做”“我们到底应该怎样做”“怎样做才符合医学伦理”等一系列伦理决策难题。

2. 在医疗卫生实践中形成的伦理难题决策　这些伦理决策难题主要集中在临床诊疗、预防与公共卫生、药品研发、涉及人的生命科学与医学研究、卫生健康管理等不同领域。①临床诊疗工作中的伦理决策难题，例如尊重患者知情权（讲真话）与对患者保密（保护性医疗）如何把握的难题；诊断上的过度与不足确定的难题（怎样才是适度）；维持生命与放弃治疗的难题；确定医疗措施的有效与无效的难题。②预防与公共卫生工作中的伦理决策难题，例如采取强制（隔离、留观）措施与个人自由、公共利益与个人利益、个人利益与他人利益、健康利益与其他利益之间、眼前利益与长远利益如何把握的难题。③药品研发、涉及生命科学与医学研究中的伦理决策难题，例如受试者获益与社会利益、科学利益如何平衡、受试者获益与风险如何把握、受试者自愿同意中存在着无奈等。④卫生健康管理中如何平衡社会公益与公众个体健康利益之间的关系、如何把握公平与效率之间的关系、如何发挥政府主导与市场机制的作用等。

二、医学伦理难题的形成原因

（一）医学伦理难题形成的根本原因

1. 医学伦理关系的复杂化　现代社会的医师不仅要处理医患关系、医医关系和医社关系，有时还要面对如何处理不同服务对象之间的社会关系的问题，即如何公平分配医药卫生资源。伦理行为主体不仅包括医师个体或群体，还包括其他医务人员个体或群体以及医疗卫生机构；服务对象不仅包括个体患者，还包括患者群体乃至整个社会。医学伦理关系的复杂化使其调整难度增大，从而极易引发伦理难题。

2. 利益的多样化　所谓利益，即好处。一个人获得某种利益，意味着其某种需要、欲望和目的的满足和达成。人的需要是多种多样的，因此，其利益也是多种多样的，而且人们对于利益的偏好也有所差异。传统医学伦理调整的利益，主要是患者疾病得到救治，尽管医师也有自己的利益，但他们信守“始终把患者利益放在首位”的职业戒条。然而，现代医师面对的利益复杂多样：患者的利益不但包括疾病得到救治，而且包括健康得以维护、生命质量得以提高、痛苦得以减轻和消除、诊疗费用得以降低等诸多方面，甚至还包括群体乃至社会有所获益。而且医师不仅应该考虑患方利益，医方的合理利益也应该予以适当考虑。这需要医师兼顾各方利益及其偏好，兼顾利益及其偏好非常困难，极易引发伦理难题。

（二）医学伦理难题形成的某些具体原因

1. 高新医学技术的临床运用　现代医学的快速发展，使高新技术层出不穷并很快运用于临床。这些技术大大增强了医师的能力，过去不能做的事情现在能够做了，例如，生命恢复和生命维持技术能够大大延长患者的生命，生殖技术能够辅助生育，产前诊断能够鉴别胎儿的缺陷，基因技术能够运用于诊断、治疗甚至“增强”领域等。然而，这些技术同时也带来了诸多医学伦理难题：是否应该延长人的死亡过程？是否应该把家庭的神圣殿堂变成生殖生物学实验室？有缺陷的胎儿是否应该出生？应该如何控制人的基因信息？面对这些高新医学技术，医师到底应该不应该运用？应该怎样运用才符合伦理？如此等等。

2. 不同伦理学理论的指导和多个伦理原则的运用　一方面，人们往往运用有关伦理学的理论，如后果论、道义论、美德论、自然律理论、女性主义理论、儒家伦理等理论来分析和解决某些医学伦理难题。然而，在医学伦理学领域，似乎任何理论都是不完美的，我们不可能单靠一种伦理学理论来解决我们面临的所有伦理难题，人们对于这些理论不可能达成一致，争论永无休止。另一方面，人们在分析和解决医学伦理问题时，有时会适用比较公认的伦理原则，如尊重原则、不伤害原则、有利原则、

公正原则，以及团结互助原则、允许原则等，可是在运用这些公认的伦理原则时往往会发生冲突，如何平衡不同原则之间的关系，人们仍然存在争议。

例如，当医师诊断出一个患者患有恶性肿瘤时，是否应该对他讲真话，基于不同的伦理学理论和伦理原则会有不同的行为方案：道义论强调行为本身的正当性，认为对人诚实是绝对的义务，是无条件的，说谎本身是不道德的，故应如实相告，不能隐瞒病情，这也是尊重原则的要求；而后果论认为应该具体情况具体分析，如果如实相告，可能对患者造成沉重打击，使其失去生活下去的信心，导致其轻生等不良后果，则要求对其保密，这也是保护性医疗制度的应有之义；如果患者因此反而积极配合医师的治疗，能够更加忍受治疗的痛苦与不适，取得好的诊治效果，则应如实相告，这也是有利和不伤害原则的要求。这样，根据不同的伦理学理论和伦理原则，甚至根据同一理论和伦理原则，既能得出应该讲真话的行为方案，又能得出不应该讲真话予以保密的行为方案，而这两种方案显然又是矛盾和冲突的。

3. 医学伦理的传统和伦理文化的多元化　中国传统儒家医德认为，医家应该重义轻利，甚至应该尚义排利。然而，在现代医药卫生体制下，任何回避、忽视医院及其医务人员利益的想法和做法，都是不现实的，也是不应该的。要使医药卫生事业健康发展，并不是要回避利益，而应该是正确处理和对待各种利益。因此，受到医学伦理传统的影响，人们在医疗卫生实践中很容易形成医学伦理难题。

第二次世界大战以来，诞生了许多国际性的医学伦理法规，这些伦理法规得到了诸多国家和地区的医学组织的普遍接受和认可，具有道义上的巨大影响力。尽管如此，由于不同国家和地区的政治、经济、思想、文化、宗教信仰等方面的差异，医学伦理文化又不同程度地呈现出多元化状况，一个国家、地区和民族认为合乎道德的医学行为，另一个国家、地区和民族的人们不一定认为是合乎道德的。这种医学伦理文化的多样化，也很容易引发有关医学伦理难题。

4. 医药卫生体制和卫生法律制度的不完善　迄今为止，全球尚没有完美的医药卫生体制，医药卫生改革是一个全球性现象。由于医药卫生体制的不够完善，在医疗卫生实践中就容易产生医学伦理难题。比如，面对意外伤害需要紧急救治的患者，医师必须履行救死扶伤的医学人道主义职责，绝不应见死不救，但个别患者获得救治又不辞而别，医院承担的大量医药费用无法得到补偿，又会使人们感到见死难救。所以，在医疗保障制度不够完善的情况下，容易发生“见死不救”和“见死难救”的伦理难题。

一般来说，一个国家的法律体现着其主导伦理价值观：合法的一定是合乎道德的，合乎道德的也一定会得到法律的保护。医学道德尽管具有保守的一面，是对传统的继承，但同时又具有超前的一面，即对于一些新问题，医学伦理首先确立应该怎么做，但尚未被法律认可。由此在医疗卫生实践中，就容易导致医学伦理矛盾和难题。

三、顺利进行医学伦理难题决策

（一）伦理推理

医师面对医学伦理难题需要决策时，应该运用理性思维方式，深思熟虑、系统思考，从医学伦理的价值前提合乎逻辑地推导出伦理难题的决策方案。

1. 顺利进行医学伦理难题决策的伦理学理论　后果论揭示了社会确立道德规范的目的是保障社会的存在和发展，最终是为了增进每个人的利益，从而确立了道德的终极标准，在此基础上，来确立社会的道德规范体系。因此，后果论是顺利进行医学伦理难题决策的根本伦理学理论，它既是判定某一诊疗行为是否符合医学道德的理论，又是确定某一医学道德规范的理论，还是评定某一医学道德规范是优是劣的理论。因此，不论是要进行具体的医学伦理难题决策，化解医师具体诊疗活动中的矛盾，还是要解决抽象的医学伦理难题，确定进行普遍医学伦理难题决策的医学道德规范，都须根据后果论。

道义论（义务论）认为，行为是否道德，其终极的标准只能看它对行为者的品德和道义的效用如

何，只有出于义务心、为义务而义务、为道德而道德的行为，才能够使行为者实现人之所以为人，才是道德的和应该的。道义论所指的这些道义或义务，实际上就是医学道德规范，即医学道德原则和规则，它们是人类医学伦理文明的成果，是人类医学伦理文化的积淀，是确立医学道德规范的文化基础。但需要通过后果论对这些医学道德规范进行论证，当这些医学道德规范与现实道德实践发生矛盾时，需要运用后果论对这些医学道德规范进行完善；当这些医学道德规范之间发生冲突时，需要运用后果论进行协调。通过后果论论证、辩护医学道德规范，解决抽象的医学伦理难题，为正确进行医学伦理难题决策创造条件。

美德论以美德或德性为中心，关心的是道德判断者的内心。美德论认为，一个好人，即拥有美德的人应该具备某些优良的人格特征；相信一个人只要拥有适宜的美德，自然就会作出正确的道德判断，即作出合乎伦理的行为决策、评价和辩护；拥有美德和拥有更多美德的人比美德缺失和拥有较少美德的人更能作出正确的道德判断。因此，医师应该拥有美德，即应该具有良好的医德素养。而要拥有良好的医德素养，就要长期遵循社会的医学道德要求。可见，医师具有良好的医德素养显然有利于遵循医学道德规范（道义），有利于自觉地运用后果论顺利进行医学伦理难题决策。

2. 化解医学道德规范冲突的具体策略

（1）比较选择：医师基于不同的医学道德规范，会形成相互矛盾和冲突的医学伦理行为方案，面对这些医学伦理决策难题，医师可以从后果论出发，即基于社会确立道德目的和道德终极标准，对不同方案的道德价值进行比较，总的原则是：两害相权取其轻，两利相权取其重。选择对于道德目的效用更大的行为方案，即最符合道德终极标准的行为方案。

（2）接受“必要害”：医师在诊疗过程中为了取得某一好效果，有时需要付出一定的代价，但这种代价是必要的，我们称之为“必要害”。为了顺利破解医学伦理难题，有时需要我们接受“必要害”。例如，为了彻底治愈疾病，需要对患者手术，患者因此要承受手术创伤之“害”；为了治疗癌症，患者需要承受放疗、化疗副作用之“害”。手术创伤、放疗和化疗的副作用等，就是必要的损害。

（3）分级量化有关规范：医师可以把医学道德规范分成若干层次等级，在解决由于依据不同道德规范为标准而引发的医学伦理难题时，采取以次从主、以小见大、顾全大局的方式进行医学伦理难题决策，即终极医学道德优于其他医学道德；医学道德原则优于医学道德规则；特定医学道德优于共同医学道德。

（4）价值选择的先后：医师面对医学伦理难题决策，必须在相互矛盾和冲突的价值中选择其一，要选择那个或那些最值得的价值。选择策略是：内在价值优于外在价值、精神价值高于物质价值；永恒价值优于短暂价值、长期价值高于短期价值；生命价值高于健康价值；积极思考的价值优于被动接受的价值等。

（二）道德直觉

医师面对医学伦理难题，应该在已有道德实践和经验的基础上，通过跳跃式的瞬间内省，进行直接而迅速的诊疗决策。道德直觉具有非逻辑性、直接性和整体性特征。首先，道德直觉是无须进行一系列抽象概括的逻辑过程。当然，决策结果并不见得是反逻辑的或不合逻辑的，它能够以自己特有的方式达到与逻辑思维相同的结果，是逻辑思维长期沉积的瞬间爆发。其次，道德直觉以医学伦理难题的整体为出发点，完整地把握医学伦理难题，这种整体思维既不用概念分析，也不用语言表达，而是靠直觉顿悟。最后，道德直觉是在瞬间完成的，对医学伦理难题的决策是瞬间直接的把握，而不是中介过程的压缩和简化。

通过道德直觉进行医学伦理难题决策主要适用于如下情形：处于紧急状况下；具有一定道德经验的情况下；对于经过严密的逻辑推理依然无法解决的难题，也可以通过直觉进行伦理决策。

道德直觉是在职业伦理观念的长期影响下形成的对于医学伦理难题较为稳定的价值判断方式，可以直接地断定对与错。凭借道德直觉进行医学伦理难题决策并非处于感觉状态的直觉，而是一种具有理性特征的直觉。可见，医师的道德直觉能力依赖于医学伦理难题决策经验的积累。因此，尽管

道德直觉是医师跨越分析与综合、归纳与演绎等中间环节的结果，但也是超越理性逻辑而进行自由、瞬间的道德思维的结果，但它却依赖于主体长期道德经验的积淀。

（三）伦理协商

医师应该善于与患者及其家属就伦理难题解决方案进行协商，经过充分沟通，达成共识。不可否认，患者及其家属会有不同的价值观，医师解决有关伦理难题，伦理沟通和协商是达成决策共识的重要方式，这也是医患共享决策的应有之义。伦理协商一般适用于如下情形：具有重大的伦理疑难，需要保证患者完整自主性的情况；医患之间、患者与其家属之间具有严重的价值观不一致的场合。具体需要医师做到以下要求。

1. 通过知情同意尊重患者的自主性　医患双方技术信息的不对称性，决定着医师既要尊重患者的自主性，又不应该无所作为，这就要求医师通过知情同意为患者的自主选择提供充分条件，即：向患者详细解释病情；告诉患者治疗或不治疗会出现的情况；告诉患者各种可能的解决伦理难题方案；提出医务人员认为的最佳解决难题方案，争取患者及其家属的同意；告诉患者要实施的难题解决方案中的注意事项和如何配合诊疗。

2. 正确对待患者及其家属的拒绝　一般情况下，医师通过患者的知情同意尊重其自主性，执行的是医师提出的又得到患方同意的最佳方案。但是，如果医师确定的最佳方案遭到患者拒绝时，如何进行医学伦理难题决策呢？这就要求医师善于了解患方的价值观，与患方充分沟通不同方案的可能结果，经过反复讨论和沟通努力达成意见一致，最后依据确定的方案采取行动。

具体的策略是：首先，患者本人和家属的意见都应考虑，这里的家属应是与之关系最为密切的，如配偶、父母、成年子女等；其次，在患者具有民事行为能力时，患者和家属意见无法统一时，侧重患者的意见；再次，在患者不具有或丧失决策能力时，把决策权转移给其家属；最后，当医师的最佳方案遭到民事行为能力正常患者及其家属拒绝时，则应设法了解拒绝的真实理由，然后有针对性地反复做解释工作。如果这种尝试失败，则应尊重患者及其家属的选择，同时做好详细和完整的病案记录。

思考题

1. 分析临床诊疗决策与医学伦理决策之间的关系。
2. 比较普通医学伦理问题决策和医学伦理难题决策。
3. 分析影响普通医学伦理决策的因素和引起医学伦理难题的原因。
4. 如何进行医学伦理决策、普通医学伦理问题决策和医学伦理难题决策？

（曹永福）

第十七章 医学道德素质的养成

本章数字资源

医学道德素质及其教育、修养与评价一直是医学界和全社会共同关注的问题。教育是提高医学道德素质的关键手段，核心在于揭示教育规律、探索教育路径、建立教育体系。修养是提高医学道德素质的内驱动力，是医德教育内化的关键路径，核心在于关注医务人员医德修养的过程与规律、内容与方法。评价是提高医学道德素质的重要机制，是促进医德修养的有效手段，核心在于依据科学的医德评价标准，使用恰当的医德评价方法。

第一节 | 医学道德素质

人的素质包括身体素质、思想道德素质和科学文化素质。道德素质一般是指人的道德观念素质和道德活动能力素质的总和。道德素质外化的表现形式为人们的道德行为。习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话中指出，新时代中国青年要锤炼品德修为。青年要把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，不断修身立德，打牢道德根基。

一、医学道德素质的含义

医学道德素质是医务人员长期遵循医学道德而形成和表现出的一种稳定的、恒久的、整体的心理状态，包括医学道德认知、道德情感、道德意志等方面。通过修养过程，医务人员能够使行医行为始终符合医学职业精神的要求。

（一）医学道德认知

医学道德认知是指医学生、医务人员对医学道德关系以及调节这些关系的医学道德原则、规范的认识、理解和接受。认知是行为的先导。医务人员优良医德行为的前提，是必须准确掌握并根据实际情形提升对医德理论、原则、规范的认识与把握。只有准确理解相关伦理理论、原则和规范，才能以此为依据，对现实的医学道德问题与困境作出恰当的判断，做到从善如流，扬正抑邪，自觉履行医德义务，展现优良医德医风。

（二）医学道德情感

医学道德情感是指医学生、医务人员对医疗卫生保健事业及患者所产生的爱慕或憎恨、喜好或厌恶等态度的内心体验和自然流露，是医德要求在医疗实践过程中的心理反映，是医务人员对医学道德的情感体验，分正性、负性和无动于衷三类。正性的医学道德情感是对正确的医学道德要求觉得愉悦、舒适的感觉，促使体验者产生自觉向往、敬仰和仿效高尚的医德行为的情感；同时，对违背医德要求的行为有厌恶、憎恨的情感体验。负性的医学道德情感则是反感医学道德的规范与要求，否定医学的人性光辉。无动于衷则是对医学道德要求没有相应的情感体验，往往由于经验不足、对医学兴趣不高等原因导致。

一般而言，只有具备正性医学道德情感的从业者，才有可能不断实践并提升医学道德情感修养。其表现为对通过行医帮助患者能够收获快乐感、成就感和幸福感，真正认同医学职业和医学道德的理念，自觉践行医学道德行为规范。

（三）医学道德意志

医学道德意志是指医学生、医务人员在履行医学道德义务过程中，自觉克服困难和障碍的能力

和毅力。面临患者疾病治疗时，医务人员从多种可行的处置方式中，经过意志的判断与选择，自觉克服困难、排除障碍，作出最有利于患者决策的心理过程及其结果。可见，医学道德意志既包括内在的意志活动，又包括意志活动推动的行为表现。医学道德意志体现在医务人员实施医疗行为时的内在动机及其支配的行为。其核心是把患者的利益放在决策控制因素的第一位，其修养境界水平的衡量标准是决策是否总对患者最有利。医务人员坚毅果敢的医学道德意志，是医学道德行为修养的终极追求。

实践中，医务人员的医德素质具体包括仁慈、诚挚、严谨、公正和节操等。其中，仁慈是指医务人员应具有仁爱慈善和人道主义精神的品德；诚挚，就是医务人员具有的坚持真理、忠诚于医学科学的品德和诚心诚意对待患者的品德；严谨，是医务人员具有的对待医学和医术严肃谨慎的品德；公正，就是医务人员具有的公平合理地协调医学伦理关系的品德；节操，就是医务人员扬善抑恶、坚定遵循医学道德规范的品德。医学道德意志是医学道德行为的杠杆，是转化为医学道德行为的关键环节。

二、医学道德素质的价值

医疗卫生行业的特殊性，决定了医德建设的独特性、实践性、继承性和时代性等特点。在医学实践中，不仅要强调对医务人员专业理论、技能的把握，更要强调对医务人员医学道德素质的培养。医学道德素质对医务人员自身的发展有显著的影响，对医疗卫生服务的具体实践也有重要的作用。

（一）医学道德素质是建设健康中国的必然要求

习近平总书记指出“没有全民健康，就没有全面小康”。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基本条件，是国家兴旺发达的重要标志，是广大人民群众的共同追求。建设健康中国不仅要求我们强化覆盖全民的公共卫生服务体系，不断优化健康服务，更对医德建设提出了新的更高的要求。首先，加强医德建设是尊重生命健康权的必然要求。尊重生命健康权是建设健康中国的核心要点，加强医德建设可以为维护和保障人民的生命健康权提供精神动力和智力支持，确保人民生命健康权的实现。其次，加强医德建设有利于民生建设。医务人员的医德医风水平的高低，直接关系到人们的健康状况与生命质量，也影响着家家户户的幸福与安康。

（二）医学道德素质是社会主义精神文明建设的题中之义

道德素质建设是社会主义精神文明建设的重要组成部分。国无德不兴，人无德不立。医德建设的水平在很大程度上展现着社会精神文明建设的水平。因此，医学道德素质是社会主义精神文明建设不可或缺的重要内容，同时也是做好医疗卫生系统政风行风建设的首要内涵。在医疗活动中，医务人员的高尚情操和良好作风不但可以直接使患者在情感上受到鼓舞，品德上受到熏陶，而且可以通过患者影响其家庭、单位和社会，有利于优化社会心理，形成良好的社会氛围，促进精神文明建设。在我国医疗卫生事业发展过程中，其战略规划中必不可少的一项就是医德建设，这是凝聚医疗卫生行业共识、提高医务人员工作积极性的重要手段。

（三）医学道德素质是深化医改的重要举措

提高我国医疗服务质量，不断推动我国医学的进步，切实把医改推向纵深，让健康福祉惠及全民，这些工作都需要加强医德建设，提高医学人才的医德、医术水平。首先，医学道德素质有利于医疗服务质量的提升。目前，随着医疗服务的同质化，医疗服务水平与医务人员的道德状况息息相关。医学道德素质深刻影响着医疗服务质量、工作效率、服务态度、费用控制、对患者需要的反应性等方面。这就要求医务人员树立“一切以患者为中心”的道德观念，提升自身的医学道德素质。其次，医学道德素质有利于推动我国医学进步。医学道德素质对医学发展具有能动性。医务人员的钻研精神和探索精神推动着医学科技的飞速发展，只有在医学实践中精益求精、百折不挠，才能探索出新成果、掌握医学前沿技术、实现关键技术突破，为医学科学的进步和健康中国的建设提供科技支撑。

（四）医学道德素质是个体实现人生价值的助力

医学道德素质为个人的道德品格发展提供了一个良好参照。医学道德素质提高过程中，医务人

员会逐步建立以人为本的核心发展思想，爱岗敬业，忠于职守；诚实守信，真诚待人，以信义作为行医之本；与患者真诚沟通，以为患者排忧解难为己任。这些都有利于进一步坚定医务人员理想信念，有利于进一步完善医疗道德规范，有利于引导医疗卫生事业发展，实现医务人员个体的人生价值。

三、医学道德素质的养成途径

医学道德素质是主客观因素相结合形成的结果。其中医务人员是主观方面的因素；社会和医学院校、医疗机构为医德建设提供物质条件和发展环境，直接作用于医德建设，是影响医德建设的客观因素。因此，医学道德素质的养成需要从主客观两方面下功夫。

（一）加强理论学习，改造主观世界

科学文化知识是医务人员陶冶自身情操的知识来源，医学伦理学知识体系是医务人员提升自身医德修养的理论指南。医务人员除了要认真学好医学专业理论知识，还应该增强自己的医学伦理学理论学习，用优秀的思想文化改造自身的主观世界，提高自身的医学道德素质。要适当拓宽自己的学习领域，广泛涉猎人文社会科学知识，如文学、哲学、心理学、社会学等。当医务人员掌握的各类学科知识越多越丰富时，其精神世界也就越丰富，同时，他们对医学道德素质的认识也就更为深入。总之，只有掌握了相应的医学伦理学知识体系，医务人员才能实现医学道德素质的提升。

（二）提高思想认识，确立医德信念

在积累相应的医学伦理学知识之后，医务人员会在此基础上逐渐形成相应的医德信念。这种逐渐积累的医德信念，是医务人员对其岗位工作认可的体现，也是其对信仰进行追求的体现。只有使医务人员加深对医学道德的认知、加强对医德情感的培养，巩固对医德意志的锻炼，才能使其具有明确的目标、自觉的行为和持续的自制力，从而自觉遵循医学伦理原则及相应的规范。

（三）养成良好习惯，注重行为实践

医学道德素质养成的过程，是医务人员将医学伦理原则与规范转化为自觉实践行动，从而使医德品质形成和完善的过程，是一个不断认识、不断实践、再认识、再实践的复杂的长期的过程。在这个过程中，既要保持良好的医德行为，也要养成良好的医德习惯，这是对医务人员医学道德素质进行衡量最为客观的重要标志。良好习惯的养成要依靠法规、传统习惯及习俗等的他律，更要依靠医务人员的高度自觉性。医务人员要在从诊断到治疗，从用药到手术，从医疗到护理等医疗行为的全过程中，把医德规范内化为自觉行动和工作习惯，切实用理论的武器指导实践，为患者提供优质、高效、便捷、可及的医疗服务，推动医德建设不断向前发展。

第二节 | 医学道德教育与修养

提高医学道德素质，教育与修养是两个重要抓手。医学道德教育向医学生传授医学道德规范，其起点是通过外界力量促使医学生接受和遵循相应行为规范，以达到塑造良好医德品质的目标。但医学道德教育不可能一蹴而就，教育目标的实现需要通过受教育者内化于心的过程后，才能外化于行。而内化于心主要依靠个人的修养。医学道德修养贯穿医务人员的一生。这要求医务人员能够随时更新医德认知、升华医德情感、坚定医德意志，这一修养的过程实际上是医务人员发挥内在道德控制与自我监督力量，化解医患双方医学知识和技术信息不对称性问题的内部路径。

一、医学道德教育与修养的含义

医学传承过程中，医学道德始终是不可或缺的重要内容，是医学教育的核心内容。

（一）医学道德教育的含义

1. 医学道德教育的概念　医学道德教育是指在医学教育和医疗卫生实践中，遵循道德教育的基本规律，对医学生和医务人员系统地开展医学伦理精神传承、医学伦理文化培育、医学道德规范灌

输以及如何转化为职业行为的教导和训练过程。其目的是围绕业已成熟并不断创新的医学道德的文化、知识和实践体系，提升职业道德境界、有效激发职业情感、严格规范职业行为、培养良好职业习惯。

2. 医学道德教育的规律　关于道德教育的一般规律是内外化机制。内外化机制是道德行为发生的最重要的心理机制，反映了道德心理形成和道德行为发生的基本规律。内外化机制具体分为内化（internalization）机制与外化（externalization）机制两个方面，即“内化于心，外化于行”。内化是指个体接受和遵循外在的各类道德规则，与个体既有的内在因素相融合，进而形成主体内在的道德观念、情感、判断能力等核心道德态度的过程与规律。外化则是个体将已形成的道德观念、情感、判断能力等核心道德态度，在具体的情境中，通过整合并表现出相应道德行为的过程与规律。内化外化虽然可以分为两个阶段，但由于心理过程的流动性特征，两者不是截然分开的，而是相互衔接与渗透，快速地相互转换与影响。

（二）医学道德修养的含义

1. 医学道德修养的概念　在中国传统文化中，修养是指按照儒家、道家等思想要求培养完善的人格，使言行合乎规矩，达成理想的人格。现代汉语中，修养多指个体在道德层面，能在外界的指导影响下，自我培养出高尚的道德品质，有合乎社会主流价值观念的待人处世态度，恰当地处理与他人、与社会的关系，并不断求取学识品德之完美状态。

医学道德修养（medical moral cultivation）是医务人员自觉遵守医学道德规范，将医学道德规范的要求转化为自己内在的道德品质的活动。其含义有两个层面：一是医务人员自觉学习与践行医学道德规范，将医学道德规范内化为自己内在道德素养的有机组成部分，并在实践过程中自觉地表现为符合规范要求的行为。二是医务人员在医学实践活动过程中，能够自觉地反思和发现职业活动中道德修为的不足，通过自我反省、自我教育和自我训练，始终坚持提升医学道德理论和实践水准的过程。可见，医学道德修养是一个永无止境地不断追求高标准的过程。医学道德教育是灌输医学伦理理论、训练医学伦理技能与实践医学道德规范的过程。知识和能力的保持需要不断地复习与重复，才能持久地呈现。在医学实践过程中，医务人员总会面对不同的伦理原则和规范、需要平衡与患者及同行的利益关系，遇到教科书没有论及和覆盖的新的伦理困境。此时，根据已知的原则和方法，独立进行伦理判断与决策，要求医务人员自我成长，具备高水平的自省与自律能力，这需要医务人员医学道德修养作为强有力的道德能力支撑。

2. 医学道德修养的意义　医学道德教育向医学生传授医学道德规范，其起点是通过外界力量促使医学生接受和遵循相应的行为规范，进而达到塑造良好医德品质的目标。如果医学生在学习阶段及其走向工作岗位之后，能够自觉地通过主观努力，修正不足、培养德行，就可以表明道德行为主体有了根据医学实践的具体情况，以相应的规则为指导，进行伦理判断和伦理决策的实际能力，表现出了较高的医学道德修养能力和水平。高水准的医学道德修养，有利于医疗服务质量的提高、医患关系的改善。

然而，医学道德修养不是一蹴而就的，这也就决定了其过程需要久久为功，贯穿医务人员的职业生涯。不论是医学生还是医务人员，在执业过程中会不断地遭遇不同类型的医德难题，也会遇到各种各样的诱惑。对此，大学阶段的医学道德教育肯定不能确保受教育者总是保持高水平的医学道德境界。医学生及医务人员需要不断巩固其医学道德修养及能力，一直保证医德认识更新、医德情感升华、医德意志坚定、医德行为高尚。

二、医学道德修养的目标和境界

医务人员进行医学道德修养的目标是养成良好的医德素质，提升自己的医学道德境界。医学道德修养的境界是指一个医务人员经过医学道德修养所达到的不同层次的医德素质水平，也称医学道德境界。实践中，医德境界按从高到低可划分为四种。

（一）最高境界

最高境界是大公无私的医德境界。其特点主要为：医务人员把有利于患者、集体和社会作为职业行为准则，自觉坚持，持之以恒；凡事先为患者、集体和社会着想，把维护患者、集体和社会的利益作为自己的天职；对患者、同事极端热忱，对工作极端负责，对技术精益求精，全心全意为人民的健康服务；时时、事事、处处体现毫不利己、专门利人的精神；把患者的康复、医疗卫生保健事业的发展作为自己的追求和幸福等。就实际状况而言，处在这一境界的医务人员是少数，但社会主义医德倡导和鼓励医务人员积极追求这种价值取向、职业理想和大医风范。

（二）较高境界

较高境界是先公后私的医德境界。其特点主要为：在职业实践中，医务人员凡事首先考虑患者、集体和社会，然后考虑自己，虽然也考虑个人利益，但总是把患者、集体和社会的利益放在个人利益之上；关心患者的疾苦，严于律己而宽以待人；对工作认真负责，愿意多作贡献而不计较报酬；当个人利益与患者、集体和社会的利益发生冲突时，不惜牺牲个人的利益等。先公后私的医德境界是大多数医务人员应该追求和完全可以达到的境界。

（三）较低境界

较低境界是先私后公的医德境界。其主要特点为：主观为自己、客观为患者，先为自己打算、后为患者打算。目前，少数医务人员处于先私后公的医德境界。他们信奉的是利己第一，兼而利人，在医疗卫生保健服务中主观上多少会考虑患者、集体和社会的利益，在满足个人私利的情况下，也会在一定程度上为患者、集体和社会的利益着想。但是，当个人利益与患者、集体和社会的利益发生冲突时，他们会变得犹豫不定，最终可能以牺牲患者、集体和社会的利益而满足个人的利益。这种医德境界滑向最低层次的可能性很大，所以必须严加防范。

（四）最低境界

最低境界是损公肥私的医德境界。其主要特点为：处在这种境界中的医务人员把医疗卫生保健服务作为获得名利的资本和手段。他们或者“钱”字当头，设法从患者身上索取钱财；或者“名”字当头，不经过患者知情同意，通过随意获取生物、遗传材料进行研究而捞取荣誉等。实践中只有极个别医务人员处于这种医德境界之中，但这会严重损害患者健康权益，败坏医疗卫生保健行业的声誉，很容易引起患者和社会的高度关注和舆论谴责，影响医患关系的和谐与医患之间的信任，后果极其恶劣并产生放大效应，必须坚决抵制。

在以上四个层次的医德境界中，最高和较高境界属于社会主义医德境界的范畴，其中大公无私的医德境界属于社会主义医德的最高层次，是共产主义道德的体现，而较低和最低境界都不属于社会主义医德境界的范畴，不符合社会主义医德的基本要求。

三、医学道德教育与修养的过程

医学道德教育的目标，是将医学道德的理念内化到受教育者的价值体系之中，使得其在行医过程中自然而然地表现出规范的职业道德行为。同时，医务人员进行医学道德修养必须坚持实践。这就要求医务人员一方面要在医学发展和临床实践中进行医学道德修养，另一方面要在有关医学道德实践中进行医学道德修养。

（一）医学道德教育的过程

道德教育产生作用的基本过程是由他律向自律的发展过程。他律是指受个体以外的价值标准所支配，表现为对外在道德准则的服从或抗拒，控制力量是外部的奖惩机制，个体关注的重点是行为后果，缺少主观的动机。自律是指自觉地遵循内心认同的道德规范进行自我指导，并以此进行自我反省、自我提升的过程，表现出对内心道德准则的服从，控制力量是内部的自我肯定或批评，个体关注的重点是行为的动机。

在医疗卫生活动中，医学职业行为受到相对完整的行为规范体系的约束。这也就是说，规制医务

人员行医行为的，不是单个规则、单个规范，而是由技术规范、道德规范、法律规范等多重规则构成的、成系统的规范体系。只有同时遵守医学道德规范、医学技术规范和相应的法律规范，行医行为才合乎医学活动的根本要求。在三种规范中，尽管医务人员的行医行为是否合乎技术规范对于疾病的诊断治疗更有指导意义，但实践中患者和公众最敏感的行医规范往往是道德规范。如在看病的过程中，患者与家属更多地关注医务人员在行医过程中的态度表现，并以此确立对医务人员喜爱或反感的态度。对道德规范行为敏感是人际交往过程中情感先导效应的表现。从内容上看，医学道德规范要求医务人员在行医过程中表现出人格的高尚与伟大，在面对求医者时表现出关心、耐心、同理心，全心全意为患者着想与服务。

（二）医学道德修养的过程

坚持实践是医学道德修养的根本途径，例如发现、分析、探讨和解决医学伦理问题甚至难题，开展医学道德评价，践行医学道德，接受医学道德教育等。

首先，医学发展和临床实践是产生医学道德问题的源泉。医务人员只有在医学发展和临床实践中，在处理医学伦理关系时，才能认识到哪些行为是符合医学道德的，哪些行为是违反医学道德的；才能运用医学道德规范调整和指导自己的行为，使自己的行为符合医学道德要求，从而使自己的医学道德境界不断提高。那些脱离医学发展和临床实践的“闭门思过”“修身养性”等，无法实现医学道德修养的目标。

其次，医学发展和临床实践是医学道德修养的目的。医务人员通过医学道德修养提高医学道德水平，更好地进行医学发展和临床实践，以达到医学维护和促进人类健康的根本目标。

再次，医学发展和临床实践是推动医学道德修养的动力。医学发展和临床实践会带来和引发大量医学伦理问题。这些问题需要一一进行研究和应对。医学发展和临床实践不断地推动医学道德的发展和变化，从而也要求医务人员及时地了解、掌握，并指导自己的医学道德修养，调整自己的医学道德观念和行为，以适应医学道德发展和变化提出的医学道德要求。

最后，医学发展和临床实践是检验医学道德修养效果的标准。医务人员通过医学发展和临床实践，并对照医学道德要求，肯定医学道德修养的成效，并找出不足或差距，从而不断地加强医学道德修养。

四、医学道德教育与修养的方法

道德教育从来没有单一的路径或方法，总是在生活的方方面面不知不觉地发挥作用。但是，基于医学生的年龄结构特征及道德发展水平，医学道德教育具有相对稳定的路径和方法。同时，道德修养意味着自我监督、自我批评、自我限制、自我改正、自我提升。

（一）医学道德教育的方法

1. 课堂教学　医学道德教育的首选方法是课堂教学。通过精心设计的教材和课堂教学，让受教育者获得系统理论与行为指导，并以考核的方式来验证教学效果。医学道德学习与社会公德、家庭道德教育学习的方式有较明显的区别，一般不是从道德行为的训练养成着眼，而是从基本的医学伦理理论学习入手。其中突出的问题是，青年已基本形成其人生观与价值观，在接受新的、关于职业准则知识与规范的过程中，存在着认知选择与整合过程。只有那些被真正接受并整合进人生观和价值观的道德规则与理论，才能实际发挥作用。换言之，课堂讲授的医学伦理理论知识、行医行为准则，即使学习者能够通过相关的知识考核，但并不一定能够成功内化于心、外化于行。学习者的人格特征、兴趣爱好、同理心等因素，都会对医学道德的内化产生关键性影响。因此，通过特定形式，挑选出适合医学职业的青年人进入医疗卫生行业，是培养综合素质优秀的医学人才的关键因素之一。相关研究及实践表明，采取理论结合实际、案例讨论与分析、伦理查房、撰写相关论文等具体方式，有利于强化学习效果。

2. 模仿学习（imitation learning）　又称为社会学习，是指人类学习某种新行为模式，只需要通过观察另一个人的行为及其结果，而且并不需要外界的强化，就能够表现出完全相同的行为。模仿学习

的前提是模仿者内心认同该行为及其结果是正确的、合理的和有价值的，对该类行为的情绪体验是正面的，就会通过自我肯定的促进机制再现他人的行为。

模仿是人的天性，模仿学习是医学道德教育的无形育人方式，是社会环境育人的核心路径。授课的老师、带教的前辈、社会塑造的榜样典型、其他医务人员的行为表现，都会不知不觉地成为模仿对象。在现实生活中，医务人员的从业环境与社会文化也存在着相互作用。从这个角度看，有效的医学道德教育还需要构建规范的医疗卫生行业文化。

3. 角色扮演（role playing）　是医学道德教育的虚拟实践学习方式，是一种情景模拟活动。在医学道德教育过程中，要求学习者在模拟的医疗活动情景中，扮演指定的医务人员或患者角色，进行模拟的诊疗活动。在扮演指定角色的过程中，能够唤起相对真实的内心活动，体验人与人交往的实际过程，从而唤醒医学生的同情心与同理心，间接检验课堂学习的有效性，强化其良好的职业道德行为模式。

4. 志愿服务　是医学道德教育的一种实践活动。其具体方式是要求医学生到医院为患者提供特定时长的特定服务。志愿服务的过程，是医学生通过体验实际的医疗卫生活动，尤其是在与患者的接触与沟通中，检验自己学医的初心是不是符合医学实践的要求。志愿服务可以有效增强医学生对医师职业的认同感。那些真心认同医学职业精神的从业者，对医学道德具有较高的认可度与接受度，在职业活动中更能亲身践行医学道德要求。

（二）医学道德修养方法

一个人能够真正做到“慎独”不是一件容易的事情，医学道德修养也不例外。医务人员医学道德修养的精进，必须有适宜的内外条件与环境，才能获得良好的效果。在医学发展的历史上，有医学道德修养成功的诸多案例，为医学生积累了可资借鉴的方法。

1. 内省法（introspective method）　我国传统文化对于内省法有着丰富的论述。内省法是指通过反省自己的所思所行是不是符合相关的道德要求和行为准则，通过自我检查以发现和找出自己思想和行为中的不良倾向、念头、行为、习惯，并加以克服和整改，从而提升道德水平的方法。

内省的方法之所以能行得通，是因为人的自我意识都有主我与客我之分。“主我”是指真实的那个自己，“客我”是指自己评价中或者别人评价中的那个自己。医学道德修养的内省方法是指医务人员根据医德理论、原则和规范，对自己医学伦理学习和执业行为过程，主动或被动地进行自我评价、判断、批评、改造，并以此为起点，自我促进医学道德水平进步的方法。

具体而言，医学道德修养的内省包括两个方面：一是理论学习过程中的内省，是指在学习相关医学伦理理论时，省察自己对相关知识的真实认识、情感，觉察自己认识的正确性，及时修正自己错误的观点及情感体验。只有通过这样的内省过程，才能将医学伦理的基本准则有效整合成为人生观、价值观的有机内容，才能够内化为职业态度，从而真正发挥作用。二是实践过程中的内省，是指在进行医学实践活动的过程中，省察自己的行为及其背后的观点、态度，是不是与规范相一致，及时发现自己的错误行为及其支配观念，并加以辩驳、纠正，从而在下一次的实践过程中表现出恰当的行为。

2. 学习法　《论语·里仁》有“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”的论述，就是指道德修养的学习法。医学道德修养的学习法是指在医学职业活动中主动见贤思齐，见到比自己表现好的就要学习追赶，见到那些不合乎道德要求的行为，要及时省察自己是不是也有类似的不当行为的方法。

医学道德修养学习的主要对象有两类：一是公认的医德典范，二是身边的医务人员。公认的医德典范，古有“杏林春暖”的董奉，现有“共和国勋章”获得者钟南山、屠呦呦等，他们是医学道德的坚定践行者，全方位地表现出崇高的医德境界。医务人员通过学习这类典范的事迹，向医德典范看齐，逐步提高自己的医德修养。身边的医务人员也是每一个医务工作者学习的对象。尺有所短，寸有所长。在日常的工作中，一种道德修养的方式就是时刻留心周围人的优点与长处而主动学习，将同行的不当之处作为前车之鉴加以避免。

3. 慎独　慎独是中国传统文化倡导的道德修养方法。慎独一词出自《礼记·大学》:“此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也”,它始终是富有特色的道德修养方法。慎独强调有修为的君子,应该人前人后行为一致,有人知无人知行为一致。在医学道德修养中,慎独是相对于共处而言,是指医务人员在无人知晓与评价的独处时,自觉按照医学道德要求践行医德的境界。

综上所述,内省法、学习法、慎独等作为医学道德修养方法,都需要修行者具有高度自觉性、坚韧性、自制力,属于道德自律范畴。

第三节 | 医学道德评价

医学道德评价是医学道德发挥作用的核心环节和主要路径。人们总是借助医学道德评价,影响甚至干预医学伦理行为,以激发更多合乎道德的医学伦理行为,从而使医学人际关系和谐。

一、医学道德评价的概念

医学道德评价(medical moral evaluation)是人们对医务人员的医学行为和活动进行的道德价值判断。医学道德评价分为抽象医学道德评价和具体医学道德评价,前者的功能或价值是确定医学道德规范;后者的功能或价值在于使医务人员遵守医学道德规范。通常所说的医学道德评价,一般是指具体医学道德评价。

(一) 医学道德评价的主体、客体和结果

医学道德评价的主体是医学道德评价者,既可以是医务人员,又可以是其服务对象;既可以是患者及其家属,又可以是其他社会成员或组织;既可以是医务人员自己,又可以是医疗卫生管理者和其他医务人员。医学道德评价的客体即评价对象,包括医务人员的医学伦理行为及其品德。其中的医务人员,不仅是一线的医务工作者,还包括更广泛意义上的医学从业人员;医学道德评价的具体对象是医学伦理行为,评价者一般会依据医务人员具体的外在的医学伦理行为表现,进一步得出其内在品德的评价结论。医学道德评价的结果是对被评价对象的“善与恶”及其程度作出评判。

(二) 医学道德评价的意义

1. 培养医学道德修养　在医学道德评价过程中,医务人员明确了社会的医学道德标准和人们对医务人员特定行为的好恶,规劝有不良行为的医务人员。医学道德评价总是会触动被评价者的内在良心,启动其反省机制,促使其自觉地遵循医学道德原则和规范,达到扬善抑恶、从善拒恶的目的。

2. 调节医学职业的道德生活　道德的调节行为作用包括内外两个方面,即内在的良心和外部的舆论。通过广泛深入的医学道德评价,肯定和赞扬符合医学道德的行为,否定和批评不道德的行为,既使得医德良好的医务人员内心愉悦及产生良好的自我评价,医德不良的医务人员内心感受到压力从而形成自我否定,又使得良好的行为广泛传播,并得到更多医务人员的效仿。

医学道德评价的他律,与医务人员内在良心的自律产生共鸣,内外力量合二为一,自律他律相互支持与印证,共同创造出良好的医学道德氛围和社会风气。

3. 推动技术与人文的和谐统一　现代医学被诟病的一个表现是在技术高速发展的同时,渐渐忽视了对人的关怀,人文温度不断下降。全社会的医学道德评价促使医务人员从仅仅关注疾病诊治技术回归到关注、关心和关爱人,提升医学的人文温度,实现医学技术与人文的和谐统一,从而能够促进全社会对医学的理解和支持,推动医学的发展和进步。

二、医学道德评价的标准与依据

医学道德评价的具体标准是根据社会进步和医学发展等条件确定的相应医学道德规范体系。这些具体标准是客观的、历史的和现实的。随着条件的发展变化,需要调整与完善医学道德评价标准。在对医务人员的品行进行评价时,究竟是看行为的动机还是看行为的效果,是看行为的目的还是看行

为的手段，这就是医学道德评价的依据问题。

（一）医学道德评价标准

医学道德评价的标准包括终极标准和具体标准两类。医学道德评价的终极标准是医学的目的。医学的目的是判断医学道德行为善恶、医务人员品德优劣的终极价值尺度。凡是符合这个目标的行为属于善行，凡是偏离这一目标的行为或者是恶行，或者没有实际的医学价值和意义。

医学目的的确定，需要诸多条件。特定历史阶段的医学科学技术发展水平、社会投入医学领域资源的多少、社会特殊的文化背景与价值观、自然环境条件等，都是确定医学目的需要考虑的因素。综合考虑上述因素，医学的目的包括：①预防疾病和损伤，促进和维护健康；②解除由疾病引起的疼痛和痛苦；③对疾病进行照料和治疗，对不治之症患者进行照料；④避免过早死亡，追求安详死亡。

（二）医学道德评价的依据

1. 动机与效果相统一　动机是指实施某种行为之前，启动该行为的内在因素，即思想中的行为。医务人员在实施诊疗疾病、维护和促进健康的行为之前，一般是基于帮助他人战胜疾病、提高健康水平的内心愿望，这是动机。动机论重视和强调动机的重要性，认为对行医行为正当性的评价应考察其动机，以动机为依据，医学道德评价主要看行为动机的良好与否。

效果是指实际实施的某种行为，以及行为直接导致的结局，即实际中的行为。医务人员实施行医行为，对行为对象产生或好或坏的影响，就是效果。效果论看重实际的行为，认为对行医行为正当性的评价应考察其后果，以后果为依据，后果直接影响个体或社会受益，医学道德评价主要看行为效果的良好与否。

在实际的医学道德评价过程中，应该坚持动机与效果的辩证统一。

首先，动机评价与效果评价存在着区别。动机是内在的主观因素，是行为的支配力量；效果是外在的客观因素，是行为的实际影响。由于受复杂因素的影响，行为的动机与效果在很多情况下并不一定完全一致。良好的动机未必有良好的效果，不好的动机有时候也能导致好的结果。从另一个角度看，同一行为后果，动机未必相同；同一动机驱动，结局可以相异。如实施治疗之前，取得患者的知情同意是基本伦理要求，也就是说不能欺骗患者。可是，为了避免对患者造成不良影响，对某些不良病情和预后需要对患者保密甚至说“善意”的谎言。所以，单独评价动机或效果，有可能导致评价结论的偏差。

其次，动机评价与效果评价存在着关联性。动机与效果具有密切的关联性，动机与效果共同构成完整的医学道德行为，并且在一定条件下相互影响与转化。一般而言，良好的主观意愿，能够引发良好的行为，并反过来促进形成更好的主观意愿。

值得注意的问题是，动机的良好，不能仅依据当事人的主观报告，而是需要考察其实施促进健康行为时的具体行为过程，例如是否努力学习和掌握医学知识与技术、是否严格执行医学技术规范、是否认真遵循医学道德要求等。如果在这些方面都表现良好，但还是出现因某些因素导致的不良结果，就应该以动机为准。反过来看，执业态度不认真、业务不熟练，即便是歪打正着有好的结果，该行为也不值得肯定和赞扬。

在具体评价时，还需要注意如下两点：①对具体医学伦理行为进行道德评价时侧重效果，即不能仅仅依据医学行为动机，而要同时考虑医学行为效果。②对医务人员的医德品质进行评价侧重动机，不能仅看行为之实际如何，还要看行为之观念如何。也就是说，医学行为动机最能体现医务人员的医德品质如何。

可见，医学道德评价是从每一个具体医学伦理行为开始的，此时侧重依据行为效果；在明确医学效果如何的基础上，考察医学行为动机的善恶；当医学动机和效果好坏明确之后，侧重医学行为动机。同时在对医务人员的医德品质进行公正评价时应坚持长期的观点。

2. 目的与手段相统一　目的是指人们行为想要达到的目标。例如，给角膜受损的患者移植角膜使其复明，让失明患者复明就是目的。目的论认为，评价行为善恶，只需依据行为目的，即只需看行为

的目的是否合乎道德，至于达到这个目的而采取何种手段并不重要，手段并不具有道德评价意义。

手段是指人们在达到行为目标的过程中所采用的方式、方法等。例如，要给角膜受损患者移植角膜，有人采取如下手段：从一位刚去世、没有表达组织捐献意愿的患者身上获取角膜。手段论认为，道德评价只需看行为手段的道德与否，行为目的并不重要，目的不具有道德评价意义。

在实际的评价过程中，应该坚持目的与手段的辩证统一。

首先，目的评价与手段评价存在着明显区别。目的评价与手段评价的着眼点不同。在具体的执业行为中，行为目的与手段都相对明确，手段是实施过程中采取的方式方法，目的是达到的行为结果，不可混淆。

其次，目的评价与手段评价也存在着密切联系。目的和手段存在相互联系、相互依存的关系。医务人员要实现促进健康的目的，都需要依赖具体的手段；采取任何手段，也都是为了实现具体的目的。

在具体评价时，还需要注意如下几点。

（1）行为的目的合乎道德是整个行为合乎道德的必要条件：要使整个医学行为合乎道德，首先要求医学行为目的合乎道德，否则，医学行为将背离其宗旨，失去其应有的道德价值。

（2）正确认识医学行为手段的道德性：一方面，道德的医学行为有时需要“必要害”的手段。医学的复杂性决定着某些医学行为手段在很多时候对患者及其家属是一种“伤害”。另一方面，道德的医学行为还要注意以下两点：首先，医务人员选择的医学手段应该是经过医学实践证明是最佳的。其次，医务人员选择医学手段应该实事求是，至少应该考虑当时的医学发展水平、医院的设备和医务人员的技术水平以及疾病的性质等要素，进行综合考虑、慎重选择。

三、医学道德评价的方式与方法

医学道德评价需要通过一定的方式与方法来进行。实践中，常用的医德评价方式与方法主要包括以下三种。

（一）社会舆论

社会舆论是医学道德评价的常见方式。在调节医学道德行为方面，社会舆论总是发挥着重要的影响。无论是整个医疗卫生行业，还是医务人员个体，其职业道德行为经常受到社会舆论的褒贬评价。一方面，社会舆论对医务人员和医疗卫生行业的表扬、肯定或谴责、否定，都是一种强烈的精神力量，对职业行为起着调整、引导作用；另一方面，医务人员也会主动关心与医学道德相关的社会舆论，有则改之，无则加勉，使得自己的职业行为不断地趋向社会的期待。

（二）传统习俗

传统习俗是历史进程中逐渐形成的、习以为常的行为倾向、行为规范和道德风尚，也称传统习惯。传统习俗对医学道德行为具有很大的约束作用和评价作用，是医学道德评价作出价值判断和医德准则得以巩固和流传的外在形式，是医学道德价值最原始、最起码的标准。

（三）内心信念

内心信念是指医学道德信念，即医务人员发自内心的对医学道德义务的信仰和责任感，也是对自己行为进行善恶评价的精神力量。在医学道德评价中，首先，内心信念作为一种强烈的责任感，是推动医务人员对自己行为善恶评价最直接的内在动力；其次，内心信念作为深入内心的医学道德意识和准则，也是医务人员医学道德评价的直接标准；再次，内心信念包含着医学道德情感和意志等因素，可以作为一种“强制力”促使医务人员接受善恶判断的赞许或谴责；最后，它可以使医学道德评价的成果变为个体内在的稳定因素。

社会舆论、传统习俗和内心信念三种医德评价方法各有自己的特点，社会舆论是现实的力量，具有广泛性；传统习俗是历史的力量，具有持久性；内心信念是自我的力量，具有深刻性。社会舆论、传统习俗能否真正发挥作用，还要依靠内心信念。所以，医务人员应该成为医学道德信念强的人，无论有没有人监督，都要做仁心医者。

思考题

1. 医学道德素质的价值体现在哪些方面？
2. 试述医德教育的内涵及其规律。
3. 试述医学道德修养的过程与方法。
4. 试述医学道德评价的标准与依据。

（吴雪松）

NOTES

推荐阅读

[1] 李本富. 医学伦理学. 北京:北京医科大学出版社,2000.

[2] 陈元方,邱仁宗. 生物医学研究伦理学. 北京:中国协和医科大学出版社,2003.

[3] 陈晓阳,曹永福. 医学伦理学. 2 版. 济南:山东大学出版社,2006.

[4] 恩格尔哈特. 生命伦理学基础. 2 版. 范瑞平,译. 北京:北京大学出版社,2006.

[5] 孙慕义. 后现代生命伦理学. 北京:中国社会科学出版社,2015.

[6] 李禄峰,何昆蓉. 中国传统医德文化. 成都:四川大学出版社,2021.

[7] 麦金太尔. 追寻美德:道德理论研究. 3 版. 宋继杰,译. 南京:译林出版社,2024.

[8] 沃林斯基. 健康社会学. 孙牧虹,等译. 北京:社会科学文献出版社,1999.

[9] 杨念群. 再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832—1985). 北京:中国人民大学出版社,2006.

[10] 刘俊荣. 医患冲突的沟通与解决. 广州:广东高等教育出版社,2004.

[11] 李义庭. 中国机构伦理委员会建设. 北京:中国协和医科大学出版社,2013.

[12] 熊宁宁,李昱,王思成,等. 伦理委员会制度与操作规程. 3 版. 北京:科学出版社,2013.

[13] 张雪,尹梅. 伦理审查委员会:理论研究及实践探索. 北京:高等教育出版社,2014.

[14] 陈旻,李红英. 临床研究伦理审查案例解析. 北京:人民卫生出版社,2016.

[15] 翟晓梅,邱仁宗. 公共卫生伦理学. 北京:中国社会科学出版社,2016.

[16] 王文科. 公共卫生健康的伦理研究. 上海:上海三联书店,2023.

[17] 戎彧,陆伟,鲍倡俊. 世界卫生组织有关公共卫生的伦理指南. 巴璐,译. 南京:东南大学出版社,2020.

[18] 胡庆澧,陈仁彪,张春美. 基因伦理学. 上海:上海科学技术出版社,2009.

[19] 李,戈德伯格,科恩. 超越想象的 GPT 医疗. 芦义,译. 杭州:浙江科学技术出版社,2023.

[20] 李伦. 人工智能与大数据伦理. 北京:科学出版社,2018.

[21] 王明旭,赵明杰. 医学伦理学. 5 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[22] 陈化. 知情同意的伦理阐释与法制建构. 北京:人民出版社,2019.

[23] 翟晓梅,邱仁宗. 生命伦理学导论. 2 版. 北京:清华大学出版社,2020.

[24] 杨小丽. 医学伦理学. 5 版. 北京:科学出版社,2020.

[25] 孙慕义,边林. 医学伦理学. 4 版. 北京:高等教育出版社,2022.

[26] 张新庆,刘奇. 护理伦理学. 5 版. 北京:中国协和医科大学出版社,2022.

[27] 刘俊荣,严金海. 医学伦理学. 武汉:华中科技大学出版社,2019.

[28] 医师资格考试指导用书专家编写组. 2023 国家医师资格考试医学综合指导用书:医学人文概要. 北京:人民卫生出版社,2023.

[29] 杜治政. 中华医学百科全书:医学伦理学. 北京:中国协和医科大学出版社,2020.

[30] 中共中央办公厅,国务院办公厅. 关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见.(2023-03-23)[2024-04-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5750620.htm.

[31] 中共中央办公厅,国务院办公厅. 关于加强科技伦理治理的意见.(2023-03-20)[2024-04-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5683838.htm.

[32] 国家卫生健康委员会,教育部,科技部,等. 关于印发涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法的通知.(2023-02-27)[2024-04-20].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/28/content_5743658.htm.

[33] 科技部,教育部,工业和信息化部,等. 关于印发《科技伦理审查办法(试行)》的通知.(2023-09-07)[2024-04-20].https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10826/202311/content_6915814.html.

中英文名词对照索引



A

安宁疗护　hospice care　106

D

道德　morality　1
道义论　theory of duty　26

F

非目的论　non-teleology　26

G

规范伦理学　normative ethics　2

H

后果论　consequentialism　28

J

机构伦理委员会　Institutional Review Board, IRB　149
基因诊断　gene diagnosis　124
健康观　view of health　24
角色扮演　role playing　193

L

利益冲突　conflict of interest　136
伦理　ethic　1
伦理学　ethics　2

M

美德伦理学　virtue ethics　2
描述伦理学　descriptive ethics　2
模仿学习　imitation learning　192

N

内省法　introspective method　193

Q

区域伦理委员会　Regional Ethics Committee, REC　149

R

人工智能　artificial intelligence, AI　132

S

生命价值论　theory of value of life　22
生命神圣论　theory of sanctity of life　21
生命质量论　theory of quality of life　22
数字鸿沟　digital divide　132
死亡观　view of death　23

W

卫生保健制度　health care system　166

Y

医学道德评价　medical moral evaluation　194
医学道德修养　medical moral cultivation　190
医学伦理难题决策　dilemma decision-making of medical ethics　182
医学伦理学　medical ethics　1, 3
医学伦理咨询委员会　Medical Ethics Advisory Committee, MEAC　149
医学社会组织伦理委员会　Medical Association Ethics Committee, MAEC　149
医院管理　hospital management　161
医院伦理委员会　Hospital Ethics Committee, HEC　149
义务论　deontology　26
应用伦理学　applied ethics　2
元伦理学　meta-ethics　2

Z

智慧医疗　smart healthcare　131
自我意识　self-consciousness　23

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	**医学伦理学**	**第 6 版**
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

扫码查看资源
A240 3712 9914
使用说明

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 王 暄
责任编辑 王 暄 董 岳
数字编辑 徐建美 王 熙
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-37677-8
9 787117 376778 >
定 价：58.00 元